แบบประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาล
ในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ

การประเมินคุณภาพการพยาบาล เป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ช่วยยกระดับคุณภาพบริการให้สูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล อันจะนำไปสู่เป้าหมายผลลัพธ์ระบบบริการพยาบาลที่พึงประสงค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยกระบวนการเยี่ยมตรวจจากทีมคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาล ในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ผู้ประเมินจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์เอกสารโดยศึกษาทำความเข้าใจจากรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขององค์กรพยาบาล โรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในโรงพยาบาล

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานการพัฒนาคุณภาพองค์กรพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามมาตรฐาน “เกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาล ในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข” เนื้อหาในรายงานประกอบด้วยส่วนโครงร่างองค์กร สาระสำคัญ จำนวน 7 หมวด และส่วนสรุป 2) เพื่อติดตามตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กรพยาบาล สะท้อนให้องค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาลทราบระดับความก้าวหน้าของการพัฒนา โอกาสในการพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องของวงจรการประกันคุณภาพการบริการพยาบาล

องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศรีรัตนะ

มีนาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
แบบรายงานประเมินตนเอง	1
ส่วนนำ : โครงร่างองค์กรพยาบาล	
1. ประวัติ/ความเป็นมาขององค์กรพยาบาล	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร	3
3. โครงสร้างการบริหารและขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล	6
4. ลักษณะโดยรวมของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศิลาลาด	10
5. ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรพยาบาล	12
6. เป้าประสงค์ในการประกันคุณภาพการพยาบาล (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)	14
7. บริบทเชิงกลยุทธ์ (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์)	15
8. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร	16
9. สถิติการให้บริการที่สำคัญขององค์กร	16
ส่วนสาระและผลการดำเนินงาน	
หมวด 1 การนำองค์กร	18
หมวด 2 กลยุทธ์	22
หมวด 3 ผู้ใช้บริการ	25
หมวด 4 การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้	30
หมวด 5 บุคลากร	33
หมวด 6 การปฏิบัติการพยาบาล	39
หมวด 7 ผลลัพธ์ทางการพยาบาล	58
ส่วนสรุป ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ	75

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงพันธกิจโรงพยาบาลและพันธกิจกลุ่มงานการพยาบาล	3
ตารางที่ 2 แสดงเป้าประสงค์โรงพยาบาลและเป้าประสงค์โรงพยาบาล	4
ตารางที่ 3 แสดงค่านิยมโรงพยาบาลและค่านิยมกลุ่มงานการพยาบาล	4
ตารางที่ 4 แสดงการจำแนกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาลตามตำแหน่ง	10
ตารางที่ 5 แสดงการจำแนกช่วงอายุของพยาบาลวิชาชีพ	10
ตารางที่ 6 แสดงการจำแนกจำนวนบุคลากรตาม Generation	11
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง	11
ตารางที่ 8 แสดงการจัดระดับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ปี 2567	12
ตารางที่ 9 แสดงความต้องการและความคาดหวังกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	12
ตารางที่ 10 แสดงความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์	15
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ	16
ตารางที่ 12 แสดง 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก	17
ตารางที่ 13 แสดง 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน	17
ตารางที่ 14 แสดง 5 อันดับโรค Refer out	17

แบบรายงานการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนนำ : โครงร่างองค์กรพยาบาล

1. ประวัติ/ความเป็นมาขององค์กร

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 15 บ้านสำโรงระวี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มีประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาล มีดังนี้

พ.ศ. 2530	ได้รับเงินบริจาคจากพ่อค้า ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ เพื่อซื้อที่ดิน จำนวน 25 ไร่ เป็นเงิน 250,000 บาท เพื่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 14 พฤษภาคม 2531
พ.ศ. 2541	ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง
พ.ศ. 2553	ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 30 เตียง เพิ่ม 1 หลัง
พ.ศ. 2554	พระครูวิสุทธิธรรมภาร (หลวงตาสาโรจน์) รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และประชาชนในเขตอำเภอศรีรัตนะ จัดผ้าป่าซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วย มีการปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน 6 ห้อง ได้รับเงินบริจาครวม 5,000,000 บาท เริ่มเปิดให้บริการตึกสงฆ์อาพาธ เพื่อรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยชาย เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
พ.ศ.2567-ปัจจุบัน	ยกระดับเป็นโรงพยาบาลระดับ F1 ให้บริการขนาด 70 เตียง มีเครือข่ายบริการสาธารณสุข ในอำเภอศรีรัตนะ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 8 แห่ง PCC 2 แห่ง

อำเภอศรีรัตนะมีเนื้อที่ทั้งหมด 236,684 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ 37 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย 25 กิโลเมตร และห่างจากโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 90 กิโลเมตร จำนวนประชากร ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2566 จำนวน 53,086 คน จำแนกเป็นเพศชาย 26,409 คน และเพศหญิง 26,677 คน ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร

1. เปิดให้บริการ One Day Surgery (ODS)
2. เปิดให้บริการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดรูปแบบมินิธัญญารักษ์

องค์กรพยาบาล

องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศรีรัตนะ มีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเป็นผู้บริหารองค์กรพยาบาล มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาลประกอบด้วย หัวหน้างาน 5 คน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 หน่วยงาน ได้แก่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช งานการพยาบาลผู้คลอด งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง และงานการพยาบาลผู้ป่วยใน จำนวน 2 หอ (หอผู้ป่วยชายและหอผู้ป่วยหญิง) มีเตียงสามัญ 36 เตียง เตียงแยกโรค 5 เตียง เตียงพิเศษ 5 เตียง และกลุ่มงานสุขภาพจิตยาเสพติด รับผิดชอบหอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ 1 หอ (31 กรกฎาคม 2566) รับผู้ป่วย 40 เตียง

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์:

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลศรีรัตนะ

เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในเขตสุขภาพที่ 10 ด้วยคุณภาพบริการ และการส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง

วิสัยทัศน์องค์กรพยาบาล

เป็นองค์กรพยาบาลชั้นนำในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 10 ภายในปี 2570

พันธกิจ:

ตารางที่ 1 แสดงพันธกิจโรงพยาบาลและพันธกิจกลุ่มงานการพยาบาล

พันธกิจโรงพยาบาล	พันธกิจกลุ่มงานการพยาบาล
1. ให้บริการสุขภาพที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคุณภาพ	1. พัฒนาระบบบริการที่ได้มาตรฐาน 2. ให้บริการโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2. ให้บริการด้านการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางอย่างมีคุณภาพ	
3. ส่งเสริมสนับสนุนภาพเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง สามารถดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง	3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาด้านบุคลากร ระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อภารกิจของโรงพยาบาล	4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพยาบาล

สมรรถนะหลักองค์กร

1. สมรรถนะด้านการให้บริการพยาบาลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. สมรรถนะด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
3. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

เป้าประสงค์:

ตารางที่ 2 แสดงเป้าประสงค์โรงพยาบาลและเป้าประสงค์โรงพยาบาล

เป้าประสงค์โรงพยาบาล	เป้าประสงค์โรงพยาบาล
1. เป็นโรงพยาบาลขนาด F2 ที่สามารถให้บริการ One day surgery (ยกระดับเป็น F1 ปี 2567) 2. Patient and Personnel Safety (2P safety) 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (Smart Hospital) 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. มีความมั่นคงด้านการเงินการคลัง	1. การบริหารการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (Smart Hospital) 4. ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและมีความประทับใจ

ค่านิยม:

ตารางที่ 3 แสดงค่านิยมโรงพยาบาลและค่านิยมกลุ่มงานการพยาบาล

ค่านิยมโรงพยาบาล	ค่านิยมกลุ่มงานการพยาบาล
SIRAT Sustainability การพัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผลระยะยาว Integrity ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น R2R มุ่งเน้นการทำงานแบบมีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ Accountability การรับผิดรับชอบ Team work การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ	SIRAT Sustainability การพัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผลระยะยาว Integrity ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น R2R มุ่งเน้นการทำงานแบบมีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ Accountability การรับผิดรับชอบ Team work การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ

วัฒนธรรมองค์กร:

1. พบกันตอนเช้า ยกมือไหว้และกล่าวคำว่า “สวัสดี”
2. มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
3. แต่งกายสุภาพและถูกระเบียบโรงพยาบาล
4. พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ
5. ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. ตรงต่อเวลา

7. มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร

เป้าหมาย:

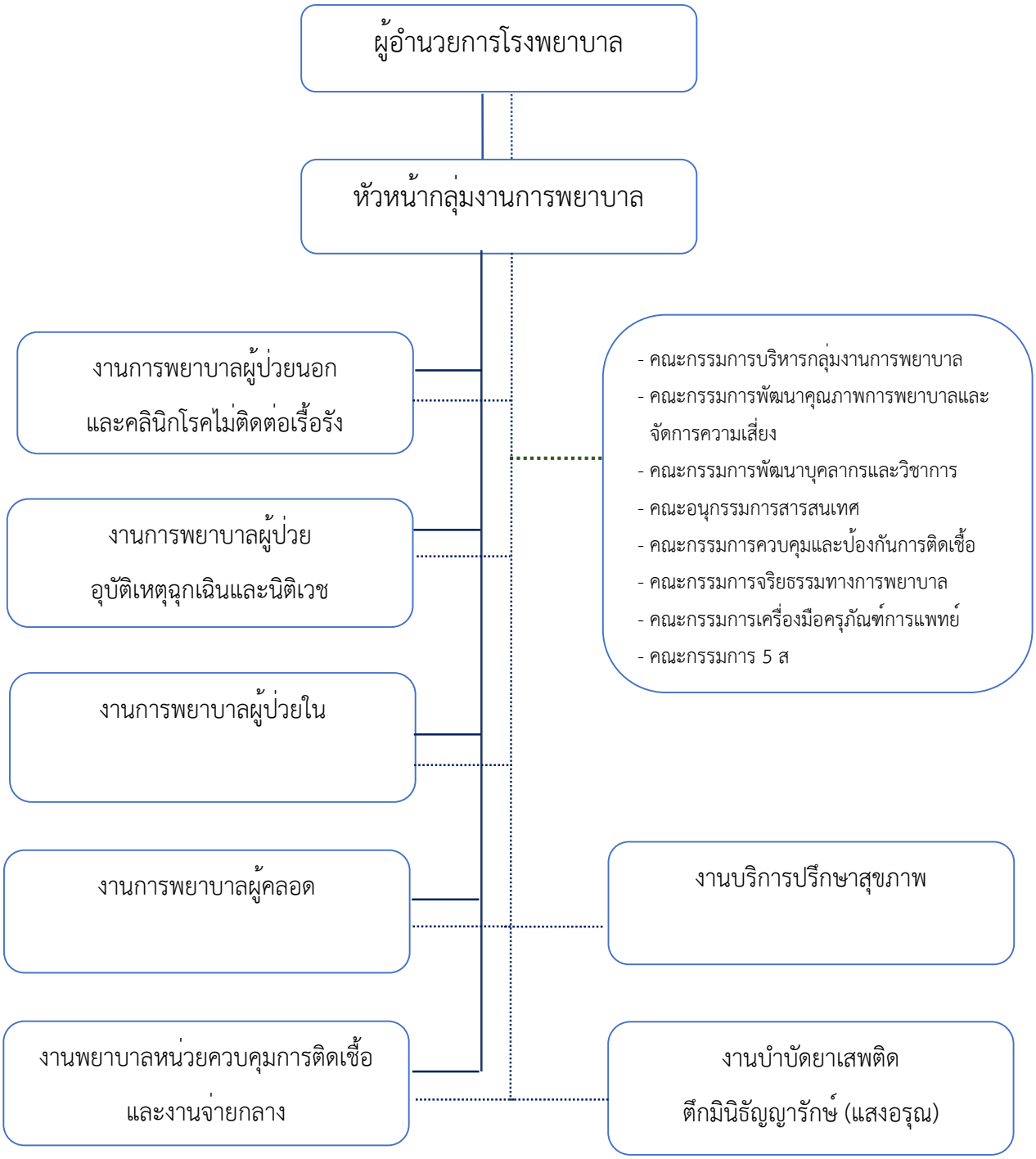
1. Service Excellence ด้านบริการเป็นเลิศ
2. Promotion Prevention & Protection ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
3. People Excellence ด้านบุคลากรเป็นเลิศ
4. Governance Excellence ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล

เข็มมุ่ง:

1. พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน QA/HA
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสารสนเทศทางการพยาบาล (Smart hospital)
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. โครงสร้างการบริหารและขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ



หมายเหตุ ——— สายบังคับบัญชา ..... สายประสานงาน

โครงสร้างการบริหาร มีหัวหน้าพยาบาลเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรพยาบาล สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีการแต่งตั้งคณะกรรมต่างๆ 8 คณะ ซึ่งพยาบาลทุกคนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล คณะกรรมการมาจากหัวหน้างานทุกคน รวม 7 คน
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและจัดการความเสี่ยง 6 คน
3. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและวิชาการ 7 คน
4. คณะอนุกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล 8 คน
5. คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในรพ. 6 คน
6. คณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรม 6 คน
7. คณะกรรมการเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 คน
8. คณะกรรมการ 5 ส 9 คน

ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล

บริการพยาบาลในความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล

1. การบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
2. การบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3. การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน
4. การบริการพยาบาลทางสูติกรรม
5. การบริการปรึกษาสุขภาพ
6. การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
7. งานจ่ายกลางและซักฟอก
8. การบริการพยาบาลผู้ป่วยบำบัดสารเสพติด (มินิธัญญารักษ์)

ด้านการบริหารบริการพยาบาล

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพยาบาล เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการของกลุ่มงานการพยาบาลมีทิศทางที่ชัดเจน

2. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการด้านอัตรากำลังพยาบาลของหน่วยบริการให้มีบุคลากรพยาบาลที่เพียงพอในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ

3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงานการพยาบาล ทั้งการสรรหาคัดเลือกบุคลากรการพยาบาล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในระดับต่างๆ การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงานการพยาบาล ทั้งการสรรหาคัดเลือกบุคลากรการพยาบาล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในระดับต่างๆ การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

5. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดขององค์กร

6. อำนวยการให้หน่วยบริการพยาบาลในความรับผิดชอบมีการวางแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

7. วางแผนและบริหารจัดการให้มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

8. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพยาบาลระดับต่างๆ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนที่กำหนด

9. ประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้งานการพยาบาลบรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

10. บริหารจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการพยาบาล

ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล

1. บริการจัดการให้มีบริการพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของโรงพยาบาลทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก ทั่วถึง และเป็นธรรม

2. กำหนดนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนให้มีความถูกต้องตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลแต่ละระดับ เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการพยาบาลที่มีมาตรฐานปลอดภัยและคุ้มค่า

3. กำหนดมาตรฐานหรือแนวทาง รวมทั้ง จัดระบบการนิเทศติดตามสนับสนุนให้บุคลากรพยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อการพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ

4. วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริการพยาบาล และความคุ้มค่าของกิจกรรมการรักษาพยาบาลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการ

5. กำหนดและอำนวยการให้มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการพยาบาล การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ

6. กำกับดูแลให้บุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายในการปฏิบัติวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อให้บุคลากรพยาบาลได้รับความปลอดภัย และมีความสุขในการทำงาน

7. นิเทศกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของหน่วยบริการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

ด้านการพัฒนาวิชาการพยาบาล

1. วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถหรือทักษะที่เพียงพอ และมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

2. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือประชุมต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความจำเป็นของหน่วยงาน

3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงานการพยาบาล ทั้งการสรรหาคัดเลือกบุคลากรการพยาบาล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในระดับต่างๆ การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงานการพยาบาล ทั้งการสรรหาคัดเลือกบุคลากรการพยาบาล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในระดับต่างๆ การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

5. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการพยาบาล

4. ลักษณะโดยรวมของบุคลากรพยาบาล

จำนวนพยาบาลวิชาชีพองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีจำนวนพยาบาลวิชาชีพทั้งสิ้น 52 คน สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 42 คน กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม จำนวน 4 คน กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จำนวน 5 คน และงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 คน บุคลากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอ ศรีรัตนะ 34 คน (ร้อยละ 65.38) บุคลากรที่มีภูมิลำเนานอกพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ 18 คน (ร้อยละ 34.62

บุคลากรกลุ่มงานการพยาบาลจำแนกตามตำแหน่ง

ตารางที่ 4 แสดงการจำแนกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาลตามตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่	จำนวน (คน)
พยาบาลวิชาชีพหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล/หัวหน้างาน	8
พยาบาลวิชาชีพ	35
เวชกิจฉุกเฉิน	3
พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14
พนักงานบริการ	8
พนักงานซักฟอกและจ่ายกลาง	7
รวม	75

ตารางที่ 5 แสดงการจำแนกช่วงอายุของพยาบาลวิชาชีพ

ช่วงอายุ (ปี)	จำนวน	ร้อยละ
22-29	11	21.15
30-34	6	11.54
35-39	8	15.38
40-44	8	15.38
45-49	10	19.23
50-54	7	13.46
55-60	2	3.85
รวม	52	100

การจำแนกจำนวนบุคลากรตาม Generation

ตารางที่ 6 แสดงการจำแนกจำนวนบุคลากรตาม Generation

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	จำนวน (คน)	อายุเฉลี่ย	Baby Boomer (พ.ศ. 2489-2507)		Generation X (พ.ศ. 2508-2522)		Generation Y (พ.ศ. 2523-2540)		Generation Z (หลังปี พ.ศ. 2540)	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หัวหน้าพยาบาล	1	59	1	1.92						
หัวหน้ากลุ่มงาน	1	44			1	1.92				
หัวหน้าหน่วยงาน	6	48			6	11.54				
พยาบาลวิชาชีพ	44	38			13	25	25	48.08	6	11.54
รวม	52		1	1.92	20	38.46	25	48.08	6	11.54

จำนวนพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง

หลักสูตรการอบรมเฉพาะทาง	ระยะเวลา	จำนวน (คน)
พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)	2 ปี	1
พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (เวชปฏิบัติชุมชน)	2 ปี	1
บริหารสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	2 ปี	2
พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวช)	2 ปี	1
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น	2 เดือน	1
ผู้บริหารการพยาบาลระดับกลาง	2 เดือน	3
การบริหารการพยาบาล	4 เดือน	6
การพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา	4 เดือน	1

หลักสูตรการอบรมเฉพาะทาง	ระยะเวลา	จำนวน (คน)
การดูแลและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	4 เดือน	1
การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	4 เดือน	8
การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน	4 เดือน	2
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	4 เดือน	2
การพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช/บำบัดยาเสพติด	4 เดือน	4/1
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์	4 เดือน	1
การพยาบาลผู้ป่วยประคับประคอง	4 เดือน	1
รวม	37 (ร้อยละ 71.15)	

การจัดระดับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ปี 2567

ตารางที่ 8 แสดงการจัดระดับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ปี 2567

ระดับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
Novice 1 - 2 ปี	6	11.54
Advance beginner 3 - 4 ปี	3	5.77
Competent 5 - 7 ปี	5	9.62
Proficient 8 - 10 ปี	3	5.77
Expertist ≥ 10 ปี	35	67.31
รวม	52	100

5. ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรพยาบาล

ตารางที่ 9 แสดงความต้องการและความคาดหวังกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการและความคาดหวัง
1. กลุ่มผู้ใช้บริการ	
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	1. การบริการที่รวดเร็ว 2. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย 3. การบรรเทาอาการรบกวนต่างๆ

กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการและความคาดหวัง
	4. การให้ข้อมูลที่ชัดเจน การสื่อสารที่ดี เข้าใจง่าย 5. พฤติกรรมบริการที่ดี
ผู้ป่วยนอก	1. การบริการที่ตรงเวลา 2. พฤติกรรมบริการที่ดี 3. ขั้นตอนการบริการที่สะดวก รวดเร็ว 4. การให้ข้อมูลที่มีความชัดเจน 5. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการรักษา
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	1. การบริการตรงเวลา 2. ขั้นตอนการรับบริการ สะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติ 3. การให้ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ 4. ได้รับบริการตามมาตรฐานรายโรค
ผู้รับบริการเฉพาะ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้พิการ OSCC ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ	 ได้รับบริการตามมาตรฐาน ผู้ใช้บริการปลอดภัย การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการรักษา ได้รับการพิทักษ์สิทธิ ให้บริการด้วยความเท่าเทียม ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ การรักษาความลับของผู้ป่วย มีช่องทางพิเศษในการรับบริการ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ผู้ป่วยใน	1. พฤติกรรมบริการที่ดี การดูแลเอาใจใส่ 2. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการรักษา 3. ต้องการหายหรือทุเลาจากอาการเจ็บป่วย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 4. ความสะดวกสบายขณะเข้ารับการรักษา
ผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์	1. พฤติกรรมการบริการที่ดี 2. การบริการด้วยความเสมอภาค 3. ความสะดวกสบายขณะเข้ารับการบำบัด
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ญาติ/ผู้ดูแล	1. ต้องการความเป็นมิตร พูดคุยด้วยไมตรีจิต 2. บริการอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ 3. ให้ความช่วยเหลือตอบคำถามหรือให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย

กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการและความคาดหวัง
	4. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 5. สิ่งอำนวยความสะดวก
สหสาขาวิชาชีพ	1. การสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ 2. การระบุตัวผู้รับบริการถูกต้อง 3. การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานที่กำหนด 4. พฤติกรรมบริการที่ดี
เครือข่ายบริการสุขภาพ	1. การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 2. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแนวทางเดียวกันกับโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่มาติดต่อราชการ	1. การสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ 2. ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
ผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาล/หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม/VIP	1. พฤติกรรมบริการที่ดี 2. การบริการที่สะดวก รวดเร็ว 3. สามารถเลือกรับบริการได้

6. เป้าประสงค์ในการประกันคุณภาพการพยาบาล (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

6.1 เป้าประสงค์เชิงปริมาณ

1) ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการพยาบาลผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

2) บุคลากรพยาบาลมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) บุคลากรพยาบาลมีปริมาณเพียงพอ มีผลิตภาพ (Productivity) ทางการพยาบาลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4) บุคลากรพยาบาลมีความพึงพอใจในงาน และมีความผูกพันยึดมั่นในองค์กร

5) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ

6) ผู้ใช้บริการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถในการดูแลตนเองได้เหมาะสม

7) แผนงาน/โครงการที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

6.2 เป้าประสงค์เชิงคุณภาพ

1) การบริหารพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2) ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ มีความพึงพอใจในการบริการพยาบาล และสามารถดูแลตนเองได้

3) บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ และมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่

7. บริบทเชิงกลยุทธ์ (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์)

ตารางที่ 10 แสดงความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงกลยุทธ์	ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาล	1. การกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 2. ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ายบริการสุขภาพ 3. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร 4. นโยบายด้านสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง	1. นโยบายด้านสุขภาพ และ Service plan มีความชัดเจน ส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 2. การจัดบริการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของโรงพยาบาล 3. โครงสร้างองค์กรมีความชัดเจน 4. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมีความพร้อม 5. มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาการบริหารการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ	1. การพัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาล 2. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการพยาบาล	1. แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับนโยบาย 2. ทีมนำทางการพยาบาลมีความมุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กร
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1. การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2. การบริหารอัตรากำลังมีความเพียงพอต่อการจัดบริการ 3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
4. การเป็นองค์กรสร้างสุข	1. การนำค่านิยมองค์กรไปสู่การปฏิบัติ 2. บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ นโยบายด้านสุขภาพในยุคปัจจุบัน	. มีค่านิยมขององค์กรที่ชัดเจน 2. มีการส่งเสริมการใช้ค่านิยมขององค์กรในการทำงานและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนสามารถดำเนินงาน 3. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 4. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถสูง สามารถเป็นแกนนำในทีมพัฒนา

	3. บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้ลักษณะงานที่มีความซับซ้อน	คุณภาพ เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของผู้รับบริการ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร

8. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร

มีการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร ตามตัวชี้วัดที่ได้มีการกำหนดร่วมกัน จากความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลุ่มโรคที่สำคัญ และบริบทของโรงพยาบาล โดยองค์กรพยาบาลรับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล มาสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ส่วนการปรับปรุงกระบวนการทำงานคุณภาพ ใช้กระบวนการ 3P หรือ PDSA มีการกำกับติดตามประเมินผลโดยหัวหน้างาน มีการส่งเสริมให้หน่วยงานวิเคราะห์กระบวนงานแต่ละงานเพื่อค้นหาโอกาสเสี่ยง และนำมากำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกัน นอกจากนี้มีการทบทวนตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรเพิ่มขึ้น มีการรวบรวมวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ โดยนำมากำหนดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ มีการพิจารณาตัวชี้วัดในกลุ่มโรคสำคัญ ให้สอดคล้องกับประเด็นสำคัญและครอบคลุมมิติคุณภาพที่สำคัญโดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามมิติคุณภาพ การให้ความสำคัญ 2P Safety PSG มีการทบทวนค่าเป้าหมาย ให้ท้าทายมากยิ่งขึ้น เมื่อมีผลลัพธ์ของงานดีขึ้น และเกินค่าเป้าหมายมากขึ้น

9. สถิติการให้บริการที่สำคัญขององค์กร

ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ

ลำดับ	ข้อมูล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ต.ค.66-ก.พ.67)
1	จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (ราย)	114,801	160,574	99,034	26,640
2	จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน (ราย)	315	440	271	293
3	จำนวนผู้ป่วยนอกคลินิกเฉพาะทาง	NA	NA	1,009	528
4	จำนวนผู้ป่วยใน (ราย)	4,221	4,298	3,048	1,059
5	จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน (ราย)	28.01	33.39	24.55	23.26
6	จำนวนวันนอนเฉลี่ย (วัน)	4.24	5.25	3.09	4.29
7	อัตราครองเตียง	122.49	152.48	84.55	84.12
8	จำนวนผู้ป่วย Refer (ราย)	2,029	3,103	3,836	886

5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

ตารางที่ 12 แสดง 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566
HT	HT	HT
DM	DM	DM
Common cold	COVID-19	Common cold
Muscle strain	Common cold	Dyspepsia
Dyspepsia	Dyspepsia	Gastroenteritis

5 อันดับโรคผู้ป่วยใน

ตารางที่ 13 แสดง 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน

ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566
COVID-19	COVID-19	Gastroenteritis
AGE	COVID-19 ร่วมกับปอดอักเสบ	Pneumonia
COVID-19 ร่วมกับปอดอักเสบ	ESRD	ESRD
ESRD	AGE	UTI
Fever, unspecified	Pneumonia	Gastritis

5 อันดับโรค Refer out

ตารางที่ 14 แสดง 5 อันดับโรค Refer out

อันดับ	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566
1	COVID-19	Calculus of kidney	Stroke
2	Stroke	Stroke	Calculus of kidney
3	Gallstone	Calculus of bile duct without cholangitis or cholecystitis	Calculus of gallbladder
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Chronic kidney disease, stage 5 (ESRD)	Fracture
5	Calculus of kidney	Senile cataract	Dyspepsia

2. ส่วนสาระ: ผลการดำเนินการ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
หมวด 1 การนำองค์กร **1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม** 1) ทีมบริหารองค์กรพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กรพยาบาล ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงพยาบาล มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผ่านการสื่อสารโดยการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ การสื่อสารในคู่มือปฏิบัติงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) มีการส่งเสริมให้ทีมผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในด้านการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกำหนดนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กรพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมของบุคลากร โดยประกาศล่าสุด ณ วันที่ 10 มกราคม 2567 โดยสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ มีการกำหนดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบริการที่ดี การอบรมเพื่อพัฒนาด้านกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ทีมผู้บริหารทางการพยาบาลสื่อสารค่านิยม “SIRAT” ในการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานแบบ “พี่สอนน้อง” มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) โดยการสร้างผลงานวิชาการ นวัตกรรม ในทุกแผนก มีการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในการประชุมวิชาการระดับจังหวัด มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังบุคลากรรายบุคคล การประชุมประจำเดือนเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การส่งเสริมกำลังใจให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทีม มีการใช้ Line application เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ มีการสอนงานโดยพยาบาลวิชาชีพอาวุโส มีการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ ผ่านระบบ Internet การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	1. แผนยุทธศาสตร์องค์กรพยาบาล 2. คู่มือปฏิบัติงาน 3. คู่มือปฐมนิเทศ 4. รายงานการประชุม 5. นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
1.2 การสื่อสารผลการดำเนินการ 1) องค์กรพยาบาลมีการสื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการสื่อสารสองทิศทาง รูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ การรับ-ส่งเวร การประชุมประจำเดือน กิจกรรม Morning Talk Line application: กลุ่มงานการพยาบาล การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ การตรวจเยี่ยมหน้างานของหัวหน้ากลุ่มงาน สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย หากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับระดับผู้ปฏิบัติจะมีการจัดประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงาน 2) มีการชมเชย ยกย่อง บุคลากรที่มีผลงานเด่นและผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรอื่น รวมถึงบุคลากรที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ มีการส่งพยาบาลเข้าประกวดพยาบาลดีเด่นระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติการ ในวันพยาบาลแห่งชาติทุกปี มีการชื่นชมพยาบาลที่ทำหน้าที่ได้ดี เมื่อมีการนิเทศงาน มีวัฒนธรรมการแสดงความยินดีเมื่อมีบุคลากรสำเร็จการอบรมระยะสั้นหรือการศึกษาหลักสูตรต่างๆ มีกิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีรัตนะ” 3) ทีมผู้บริหารองค์กรมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรพยาบาลที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ มีการถ่ายทอดนโยบายลงสู่แผนกต่างๆ โดยผ่านทางหัวหน้างาน มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้บุคลากร มีการควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดและติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและโรงพยาบาล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ผู้บริหารองค์กรจะมีการทบทวนร่วมกัน หลังจากนั้นจึงมีการสื่อสารไปยังบุคลากร	1. สรุปผลการจัดกิจกรรม Morning talk 2. เอกสาร หลักฐานการรับ-ส่งเวร 3. รายงานการประชุม 4. ภาพตัวอย่างการสื่อสารผ่าน Line application 5. รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ
1.3 การกำกับดูแลองค์กรพยาบาล 1) ทีมบริหารองค์กรพยาบาล มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามนโยบายของโรงพยาบาล มีการมอบหมายงานตามโครงสร้างบริหารงาน มีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน	1. Job Description 2. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
(Job Description) ครอบคลุมบุคลากรทุกตำแหน่ง มีระบบการควบคุม กำกับการปฏิบัติหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ มีการดำเนินงานตามระเบียบที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 2) มีการกำหนดแนวทางการกำกับและประเมินผลงานของหัวหน้างานโดยการกำกับดูแลผลลัพธ์ตัวชี้วัดทางการบริหาร และด้านปฏิบัติการตาม Clinical care ของแต่ละหน่วยงาน มีการติดตามตัวชี้วัดทุกเดือน กรณีที่ผลการปฏิบัติงานไม่อยู่ในค่าเป้าหมาย มีการทบทวนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และวางแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน 3) การประเมินประสิทธิผลของผู้บริหาร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานจากตัวชี้วัดที่ได้ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับผลการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ และการรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ในทีมคุณภาพ หรือหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย มีการนำผลการประเมินมาทบทวน เพื่อหาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารงานของหัวหน้างาน มีการใช้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นข้อมูลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในปีงบประมาณ 2566 ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการ CQI หรือนวัตกรรมเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่ม	3. สำเนาหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 4. หลักฐานการเปลี่ยนเวร 5. ข้อมูลตัวชี้วัดองค์กร 6. หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
1.4 พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายการรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1) มีการกำหนดความเสี่ยงทางจริยธรรมทางการพยาบาลที่เฝ้าระวัง ได้จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรในองค์กรเกิดความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ มีกระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการควบคุมกำกับ การนิเทศการปฏิบัติงาน การรับฟังข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ มีระบบการควบคุมกำกับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ มีระบบนิเทศทางการพยาบาล รวมถึงการควบคุมกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรพยาบาล และระเบียบของโรงพยาบาล	1. คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. คู่มือบริหารความเสี่ยง 3. คู่มือนิเทศงาน 4. คู่มือปฏิบัติงาน 5. คู่มือ ENV

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
2) มีการสื่อสารนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของโรงพยาบาล มีการควบคุมกำกับ นิเทศการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อเป็นแบบอย่างขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม เช่น การปฏิบัติตามนโยบายการแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ การแยกขยะ Recycle ให้ถูกต้อง การประหยัดพลังงานตามนโยบายคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3) องค์กรพยาบาลได้กำหนดนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์กรพยาบาล มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านจริยธรรม โดยการตรวจเยี่ยม การนิเทศการปฏิบัติงานประจำวัน การทบทวนเวชระเบียน รวมถึงการเสนอประเด็นความเสี่ยงทางจริยธรรม เมื่อมีการทบทวนความเสี่ยงทางคลินิก มีระบบการเฝ้าระวังข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมร่วมกับทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล	
1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 1) องค์กรพยาบาลคำนึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมโดยการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง ในกลยุทธ์ที่ 2 คือ การพัฒนาระบบบริการร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยกำหนดแผนงานจำนวน 3 แผนงาน ประกอบด้วย การพัฒนาระบบบริการเชื่อมโยงไปสู่การดูแลระดับชุมชน พัฒนาระบบการประสานส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วย และการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในเครือข่าย ส่วนบทบาทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน องค์กรพยาบาลมีบทบาทในการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสุขภาพหรือประเด็นที่ชุมชนวิตกกังวล เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย ข้อร้องเรียนต่างๆ รวมถึงปัญหาด้านการบริการที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับด้านจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ ชุมชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย มีการจัดนำปัญหาในพื้นที่จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ	1. แผนกลยุทธ์กลุ่มงาน 2. โครงการ 3. สรุปผลการดำเนินโครงการ 4. รายงานอุบัติการณ์ 5. คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6. รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเสีย 7. คู่มือ ENV

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
หมู่และสาธารณภัย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บทางถนน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจมน้ำ โครงการนิเทศติดตามระบบการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากนี้ ทีมพยาบาลยังมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เรื่อง การปฐมพยาบาล การป้องกันการจมน้ำ การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพคลินิกโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ การเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 3) มีการประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล โดยเผยแพร่ข้อมูลทาง Internet Social media การส่งเสริมรณรงค์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน และเป็นทีมพี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การใช้อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย Palliative ของศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ระบบการทำปราศเชื้อของเครื่องมือ การจัดการขยะ การรณรงค์คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย พบกลุ่มโรคที่สำคัญ4 กลุ่มโรค จึงได้พัฒนาการเข้าถึงแพทย์เฉพาะทาง 4 สาขาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ โรคตา โรคทางเดินปัสสาวะ โรคระบบทางเดินอาหาร (ศัลยกรรมทั่วไป) และเปิดให้บริการบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาติดสารเสพติด (มินิธัญญารักษ์) ซึ่งเป็นปัญหาของชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ	
หมวด 2 กลยุทธ์ **2.1 การจัดทำกลยุทธ์** 1) ผู้บริหารการพยาบาลทุกตำแหน่ง และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรพยาบาลมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์กองการพยาบาล ยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 10 ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผลการดำเนินงานองค์กร ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลสำเร็จจากการทำแผนยุทธศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศรีรัตนะ 4 ยุทธศาสตร์ 11 กล	1. แผนยุทธศาสตร์องค์กรพยาบาล 2. ผลการสำรวจความพึงพอใจ 3. แผนกลยุทธ์กลุ่มงานการพยาบาล

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
ยุทธ์ โดยแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่กำหนดไว้มีระยะเวลา 5 ปี (2566 – 2570) ส่วนแผนกลยุทธ์ระยะสั้นที่สุดที่กำหนดไว้ คือ ระยะเวลา 1 ปี 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรพยาบาล ใช้เครื่องมือ SWOT analysis ในการวิเคราะห์บริบทขององค์กร มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร มีขั้นตอนการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เพื่อค้นหาปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยพิจารณาจากความสามารถ/ความเชี่ยวชาญขององค์กร และกำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร 3) ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้จากข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ข้อมูลจากชุมชน ข้อมูลจากข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ข้อมูลตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งบทเรียนของการทำแผนของปีที่ผ่านมา เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ คือ SWOT analysis มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยใช้ McKinsey 7-S และ PESTEL analysis	
2.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1) องค์กรพยาบาลได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทั้งในระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (5 ปี) เพื่อเป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายที่องค์กรต้องการบรรลุ ตามกรอบระยะเวลา 2) การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ องค์กรพยาบาลได้นำความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กร และนำความท้าทายเชิงกลยุทธ์มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ที่จะต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็งสามารถรับมือกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้มีการนำโอกาสเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่องค์กรยังไม่ปฏิบัติและทีมบริหารองค์กรพิจารณาว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถขององค์กรได้ เพื่อตอบสนองปัญหาด้านสุขภาพของพื้นที่	

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
3) มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในด้านการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โดยภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพในชุมชน การให้บริการแบบไร้รอยต่อ และการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี	
2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่ไปปฏิบัติ 1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขององค์กรพยาบาลให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโรงพยาบาล มีการกำหนดแผนระยะสั้นและระยะยาว มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มีการจัดประชุมชี้แจงแผนในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้หัวหน้างานนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับทีม ระดับหน่วยงาน และตัวชี้วัดรายบุคคล มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพขององค์กรพยาบาล มอบหมายให้หัวหน้างานมีการกำกับ ติดตาม ให้การสนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2) มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยหัวหน้ากลุ่มงานนำเสนอตัวชี้วัดที่สำคัญทุก 1 เดือน และตัวชี้วัดอื่น ๆ รายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โดยได้กำหนดเป็นวาระการประชุมทบทวนของคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 3) เมื่อพบตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย กำหนดให้ทีมนำหรือผู้รับผิดชอบนำไปทบทวนและวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง 3C-PDSA/DALI จากนั้นมีการทบทวน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหากยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือนได้	1. แผนปฏิบัติการองค์กรพยาบาล 2. รายงานตัวชี้วัดหน่วยงาน
2.4 การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 1) องค์กรพยาบาลมีการจัดสรรอัตรากำลังตาม FTE ขั้นต่ำของโรงพยาบาลชุมชนระดับ F1 โดยกำหนดคุณสมบัติ และคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบ (Job description) ของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละหน่วยงาน มีระบบปฐมนิเทศ	1. แนวทางการจัดอัตรากำลัง 2. Job description 3 แผนพัฒนาบุคลากร

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
บุคลากรใหม่ มีการประเมินและพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญตามบทบาทหน้าที่ ส่วนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Service plan และเข็มมุ่งในการพัฒนาโรงพยาบาล มีการส่งพยาบาลเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเพิ่มเติมในสาขาที่จำเป็น ได้แก่ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน พยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง พยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการในสาขาต่างๆ 2) มีการจัดทำแผนการใช้เงินบำรุง งบค่าเสื่อม งบลงทุน และได้รับการพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหากยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือนได้ 3) มีการทบทวนแผนการดำเนินงานทุก 3 เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล กรณีที่พบว่า มีการปรับเปลี่ยนแผนสามารถที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	4. คู่มือปฐมนิเทศ
2.5 การคาดการณ์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 1) จากแผนกลุยทธ์ที่ได้กำหนดไว้โดยมีการกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้อย่างชัดเจน มีวิธีการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน ดังนี้ การคาดการณ์ผลก่อนการดำเนินการ ใช้วิธีศึกษาข้อมูลเดิม นำมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน โดยหัวหน้างานมีการพูดคุยและสอบถามบุคลากรถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดซ้ำ 2) วิธีการคาดการณ์ผลขณะดำเนินการ หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงาน รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการจัดประชุมเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อทราบข้อมูลที่สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ของผลการดำเนินงาน รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน 3) หลังการดำเนินงาน มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับโรงพยาบาลคู่เทียบ หลังจากนั้นผู้บริหารองค์กรพยาบาลดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อวางแนวทางปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้ดีขึ้น	1.สรุปผลการดำเนินการตามแผน 2. การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับโรงพยาบาลคู่เทียบ
หมวด 3 ผู้ใช้บริการ **3.1 การรับฟังผู้ใช้บริการ**	

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
1) การจำแนกประเภทผู้รับบริการและผู้รับผลงาน มีการจำแนกโดยพิจารณาจากลักษณะของบริการที่ปฏิบัติตามภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบ มีการจำแนกกลุ่มผู้ใช้บริการ ดังนี้ 1. กลุ่มผู้ใช้บริการ ได้แก่ -ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -ผู้รับบริการเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้พิการ OSCC ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ -ผู้ป่วยใน -ผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -ญาติ/ผู้ดูแล -สหสาขาวิชาชีพ -เครือข่ายบริการสุขภาพ -เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่มาติดต่อราชการ -ผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาล/หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม/VIP มีการกำหนดขอบเขตของการบริการพยาบาล จำนวน 8 หน่วยบริการ ดังนี้ 1. การบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก 2. การบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3. การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน 4. การบริการพยาบาลทางสูติกรรม 5. การบริการปรึกษาสุขภาพ 6. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 7. งานจ่ายกลางและซักฟอก 8. การบริการพยาบาลผู้ป่วยบำบัดสารเสพติด (มินิธัญญารักษ์) 2) องค์กรพยาบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการผ่านการสื่อสาร และช่องทางรับความคิดเห็น เพื่อนำคำติชม/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ จำแนกเป็น	1. ผลการสำรวจความพึงพอใจ 2. ตู้รับความคิดเห็น 3. Website โรงพยาบาล 4. ผลการทบทวน/การจัดการข้อร้องเรียน

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
-เชิงรุก ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล การเยี่ยมบ้าน/การลงพื้นที่ การประชุมของหัวหน้าส่วนราชการ -เชิงรับ ได้แก่ โทรศัพท์ กล่องรับความคิดเห็น Facebook จดหมาย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน มีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงตามความเร่งด่วน หากเป็นข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ มอบหมายให้หัวหน้างานแจ้งทีมพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น 3) องค์กรพยาบาลมีการปรับปรุงวิธีการรับฟังความคิดเห็นให้มีช่องทางเพิ่มขึ้น โดยการสร้าง QR code เพื่อความสะดวกในการแสดงความคิดเห็น มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการแผนกต่างๆ โดยใช้แบบสอบถาม OP และ IP voice การสอบถามความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการภายหลังการให้บริการ ส่วนการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ และการรับฟังข้อเสนอแนะจากการรับบริการ	
3.2 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 1) องค์กรพยาบาลมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการโดยกำหนดนโยบายให้บุคลากรในองค์กร มีการแต่งกายที่ถูกระเบียบ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ ให้บริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวลจะได้เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการ การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการขณะรอตรวจ การให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านโดย Exit nurse ด้านโครงสร้างอาคาร สถานที่ โรงพยาบาลได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างพื้นที่พักผ่อนและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ มีการทำกิจกรรม 5 ส ทำให้พื้นที่ต่างๆ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และปลอดภัย 2) ช่องทางสำหรับผู้ใช้บริการเพื่อการค้นหาข้อมูล หรือติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงการเสนอแนะ/ร้องเรียนในการให้บริการ สามารถใช้ช่องทางจาก Website และ Facebook โรงพยาบาล การโทรศัพท์ ในปี 2567 มีการ	1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจขององค์กร 2. แพ่นพับ เอกสารคำแนะนำต่างๆ 3. ภาพช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน, Facebook 4. หลักฐานการพัฒนาด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
สร้าง Line OA สำหรับนัดคิวออนไลน์ซึ่งสอบถามข้อมูลการเข้ารับบริการได้ และการสื่อสารผ่านระบบ Telemedicine ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3) การสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลสารสนเทศโดยสืบค้นข้อมูลจาก Website และ Facebook โรงพยาบาล มีการจัดทำวิดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการรับบริการ กระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยจากแผนกต่างๆ มีการให้แผ่นพับ เอกสารให้คำแนะนำต่างๆ มีการแนะนำการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Youtube โดยสาธิตการเปิดวิดีโอสืบค้นข้อมูลขณะให้สุขศึกษาผู้ป่วยและญาติ	
3.3 การจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 1) กระบวนการรับข้อร้องเรียนขององค์กร เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจะมีทีมรับข้อร้องเรียนเป็นผู้ประเมินความรุนแรงของข้อร้องเรียน มีแนวทางจัดการข้อร้องเรียนตามระดับความรุนแรง การแก้ไขข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงสูงเสี่ยงต่อการฟ้องร้องหรือมีผลกระทบต่อโรงพยาบาลจะมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น มีการประชุมทบทวนภายใน 1 วัน หากเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่รุนแรงกำหนดให้หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการแก้ไข 2) องค์กรพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนที่ได้รับและการแก้ไขระดับหน่วยงาน องค์กรพยาบาล และระดับโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เมื่อข้อร้องเรียนได้รับการทบทวน แก้ไขมีการตอบกลับข้อร้องเรียนโดยทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล หากเป็นข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรง เช่น ม. 41 มีทีมไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการ ตั้งแต่ปี2565 ไม่พบมีข้อร้องเรียนใช้ ม.41 3) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนมีการประเมินข้อร้องเรียนที่ได้รับว่ามีความรุนแรงหรือไม่รุนแรง เป็นข้อร้องเรียนด้านใด เช่น จริยธรรม พฤติกรรมการบริการ สิ่งแวดล้อม/สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบบริการหรือด้านอื่นๆ มีการทบทวน แก้ไขข้อร้องเรียนที่ได้รับ และเฝ้าระวังการเกิดข้อร้องเรียนในเรื่องเดิมว่ามีการเกิดซ้ำหรือไม่	1. Flow รับข้อร้องเรียน 2. สรุปรายงานข้อร้องเรียน
3.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 1) มีการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ทั้งในกลุ่มผู้รับบริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผู้มาใช้บริการอื่นๆ ครอบคลุมทุก	1. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
กลุ่ม มีการสอบถามความคิดเห็นขณะเข้ารับบริการและก่อนจำหน่าย และนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาการบริการ มีการเพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน 2) เมื่อผู้ป่วยได้รับการจำหน่าย มีการติดตามผลหลังการเข้ารักษาโดยการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยบางรายที่มารับการรักษาซ้ำ ทีมผู้ให้บริการ มีการสอบถามข้อเสนอแนะในการให้บริการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงคุณภาพการบริการผู้ป่วย 3) มีการเพิ่มช่องทางให้ผู้รับบริการที่มี Smart phone สามารถประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ได้สะดวกมากขึ้น โดยทาง QR code ส่วนผู้รับบริการที่สามารถอ่านออก เขียนได้สามารถประเมินได้โดยการตอบแบบสอบถาม ส่วนผู้รับบริการที่มีข้อจำกัด มีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม	2. สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
3.5 การสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ 1) การจัดบริการขององค์กรพยาบาล เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ มีการดำเนินการโดยกำหนดนโยบาย “ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง” การให้บริการดุจญาติมิตร การอำนวยความสะดวก รวดเร็ว สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกรับด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี การลดระยะเวลารอคอย การเปิดโอกาสให้ซักถามข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้บริการเข้าถึงง่าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 2) โรงพยาบาลมีการพัฒนาเป็น Smart Hospital องค์กรพยาบาลจึงมีการปรับระบบการบริการที่สามารถช่วยลดขั้นตอนการรับบริการและการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น การใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการเข้ารับบริการ การบริการ One stop service ระบบการจัดคิวผู้ป่วยนอก และระบบจองคิวออนไลน์ เป็นต้น 3) องค์กรพยาบาลมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เมื่อมีโอกาส เช่น การร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา หรือวันสำคัญต่างๆ การร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันศุกร์ได้นิมนต์พระมาบิณฑบาตรที่โรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติที่นอนในโรงพยาบาลได้ทำบุญใส่บาตร มีการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติทุกปี หลังจัดกิจกรรมมีการทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ใน Website, Facebook โรงพยาบาล และมีการประชาสัมพันธ์เมื่อมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน หรือ สิ่งของให้โรงพยาบาล	ภาพการจัดบริการต่างๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
3.6 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 1) บุคลากรมีการให้บริการที่คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย โดยการให้บริการที่มีมาตรฐาน การให้ข้อมูลด้านการรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติในขอบเขตของวิชาชีพอย่างชัดเจน มีการให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ เปิดโอกาสให้ซักถามก่อนให้ผู้ป่วยลงชื่อยินยอมการรักษา การติดต่อประสานงานในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการพบแพทย์ผู้รับผิดชอบ การให้โอกาสผู้ป่วยแสดงความเห็นและเข้าร่วมปรึกษากับทีมสุขภาพก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา การอธิบายให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งก่อนให้การรักษาพยาบาล มีการเฝ้าระวังข้อร้องเรียนหรือปัญหาด้านสิทธิผู้ป่วย 2) การควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยขององค์กร มีแนวทางปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร มีการนิเทศ ควบคุม กำกับขณะปฏิบัติงาน มีการแต่งตั้งพยาบาลวิชาชีพร่วมเป็นสมาชิกในทีมไกล่เกลี่ย เพื่อเฝ้าระวังการเกิดข้อร้องเรียน 3) มีการวางระบบการจัดการข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้ป่วย โดยกำหนดให้ทีมบริหารจัดการข้อร้องเรียนร่วมกับคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรม เป็นทีมหลักในการบริหารจัดการโดยมีหน้าที่ในการดำเนินการทบทวน วางแนวทางแก้ไข และเสนอรายงานต่อผู้บริหาร	1. คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 2. แนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล
3.7 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะ 1) องค์กรพยาบาลให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย การให้บริการที่ดีโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และการพยาบาลตามมาตรฐานจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้นโยบายพิทักษ์สิทธิในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะ ได้แก่ ผู้ป่วย OSCC ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ต้องทำการผูกยึด และมีการสื่อสารนโยบายไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 2) มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย OSCC ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วย OSCC ผู้ป่วยที่ต้องทำการผูกยึด สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3) การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน มีการนิเทศขณะปฏิบัติงานโดยหัวหน้าเวร และหัวหน้างาน มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว	แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย OSCC, การผูกยึดผู้ป่วย

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ **4.1 การวัดผลการดำเนินงาน** 1) องค์กรพยาบาลมีการเก็บรวบรวมตัวชี้วัดจากคณะกรรมการการบริหารโรงพยาบาล ตัวชี้วัดขององค์กรพยาบาลจากแผนปฏิบัติงานของแต่ละกลยุทธ์ ตัวชี้วัดจากคู่มือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลของกองการพยาบาล นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดตาม Service Plan แต่ละสาขา มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล มีคณะกรรมการสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากโปรแกรม HOSxP และโปรแกรม Microsoft Excel ที่พัฒนาขึ้นเอง โดยให้ส่งรายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน มีการรายงานข้อมูลการให้บริการแต่ละเวรใน Google Sheet เพื่อการบริหารอัตรากำลังอย่างเหมาะสม 2) มีการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมายขององค์กรกับโรงพยาบาลในระดับเดียวกันทั้งด้านการบริหารและการบริการพยาบาล เพื่อเทียบเคียงข้อมูลเชิงปริมาณ หากผลการดำเนินงานไม่อยู่ในเป้าหมาย จึงมีการเทียบเคียงเชิงกระบวนการ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการหาโอกาสพัฒนา โดยตัวชี้วัดที่เทียบเคียง มีจำนวนทั้งสิ้น 40 ตัวชี้วัด 3) การปรับปรุงระบบการวัดผลการดำเนินการให้ทันต่อความต้องการของผู้รับผลงาน องค์กรพยาบาลมีการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรายงาน การประมวลผลข้อมูล เช่น การรายงานข้อมูลการให้บริการในแต่ละเวรโดยใช้ Google Sheet การออกแบบรายงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่งผลให้องค์กรพยาบาลสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้รวดเร็ว ทันเวลา สามารถบริหารอัตรากำลังได้เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิตอล ตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้	1. รายงานตัวชี้วัดภาพรวมขององค์กร/หน่วยงาน 2. สถิติรายงานใน Google drive
4.3 การจัดการแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาล 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศของกลุ่มงานการพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบระบบ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางการพยาบาล ติดตาม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานการพยาบาล

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
ข้อมูลตัวชี้วัดแต่ละหน่วยงาน ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการบริการและการบริหารทางการพยาบาล บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 2) ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการพยาบาล มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีความเป็นเป็นปัจจุบัน มีความพร้อมในการใช้งาน โดยคณะกรรมการสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบออกแบบระบบ มีระบบความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบรายงานโดยการ Log in เข้าระบบ โดยมีทีมสารสนเทศโรงพยาบาลเป็น พี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา และมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทั้งโรงพยาบาล 3) โรงพยาบาลมีระบบ Hardware และ Software ที่มีความพร้อมใช้ เมื่อพบปัญหาในการใช้งาน ที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถแก้ไขได้เอง สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ทีมสารสนเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจัดเก็บข้อมูลสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว ทันเวลา	2. รายงานการจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมของกองการพยาบาล 3. Google drive รวบรวมรายงานทุกหน่วยงาน
4.4 ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล 1) คณะกรรมการสารสนเทศได้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสะดวกในการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วทันเวลา มีการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศ มีระบบการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานรายเวร รายเดือน มีการตรวจสอบข้อมูลโดยหัวหน้าเวรหรือหัวหน้างาน ส่วนข้อมูลที่เป็นรายงานประจำเดือนมอบหมายให้คณะกรรมการสารสนเทศแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบ 2) ข้อมูลที่ประมวลผลได้จากระบบรายงานสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการอัตรากำลัง เช่น ข้อมูล Productivity สามารถใช้ในการบริหารอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม ส่วนรายงานผลการดำเนินงานอื่นๆ เช่น รายงานตัวชี้วัดรายโรค รายงานความเสี่ยงทางคลินิก สามารถนำข้อมูลเพื่อทบทวนและพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมนำทางคลินิก (Patient Care Team: PCT) 3) การเข้าถึงระบบข้อมูลการพยาบาล กำหนดให้สามารถเข้าใช้งานได้โดยต้องใช้รหัสผ่าน ของหน่วยงาน ส่วนการกำหนดลำดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูล มีการกำหนด ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานประจำวันได้ทุกคน	1.โปรแกรมการรายงานกิจกรรมและสถิติทางการพยาบาล 2. โปรแกรม HOSxP ลงบันทึกข้อมูลการดูแลรักษาและกิจกรรมทางการพยาบาล

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย OSCC ผู้ป่วยคดี สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้าฝ่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลข้อร้องเรียนที่มีการระบุชื่อบุคลากร	
4.5 ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 1) ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล มีการสำรองข้อมูลการให้บริการ กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลเดิมได้ มีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ กรณีโปรแกรมให้บริการผู้ป่วยพบปัญหาที่ไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อื่นๆ เช่น เหตุการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล อุบัติภัยหมู่ มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ มีการซ้อมแผน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการบริหารจัดการในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติของ CPR Team เมื่อมีผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและต้องทำการกู้ชีพ มีระบบกริ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากห้องฉุกเฉิน 2) โรงพยาบาลมีการจัดทำแผนรองรับการเกิดอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล มีการซ้อมแผนอัคคีภัยทุกปี มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของถังดับเพลิง มีแนวทางแจ้งขอความช่วยเหลือ มีระบบสำรองไปกรณีไฟฟ้าขัดข้อง สามารถใช้งานได้ภายใน 10 วินาที เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบความพร้อมวันละ1 ครั้ง 3) บุคลากรได้มีการซักซ้อมการทำหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อมีการซ้อมแผน ภายหลังการซ้อมแผนมีการประเมินผลทุกครั้ง เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์จริง	1. แผนอุบัติเหตุหมู่ 2. แผนรองรับอัคคีภัย 3. แผนเผชิญเหตุทะเลาวิวาท 4. แนวทางแจ้งขอความช่วยเหลือ CPR Team 5. รายงานการซ้อมแผน 6. ทะเบียนตรวจสอบและสอบเทียบครุภัณฑ์ปีละครั้ง
4.6 การจัดการความรู้ 1) องค์กรพยาบาลได้กำหนดนโยบายการจัดการความรู้ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล มีหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการพยาบาล และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บในระบบสารสนเทศทางการพยาบาล เช่น ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมภายนอก อบรมภายในโรงพยาบาล ความรู้จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้กับบุคลากรทางการพยาบาลสามารถเข้าถึงได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน การปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพ และการศึกษาวิจัย	1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2. สรุปผลการอบรมของบุคลากร 3. ภาพตัวอย่างกิจกรรมการจัดการความรู้ 4. ผลงานคุณภาพที่เป็นขององค์กรพยาบาล เช่น CQI

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
2) คณะกรรมจัดการความรู้มีหน้าที่รวบรวมรายงาน สิ่งที่ได้รับจากการอบรมในระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (HRM) และติดตามว่าบุคลากรผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานในหน้าที่หรือการพัฒนาเป็นผลงานอย่างไร มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในที่ประชุมบุคลากร การส่งข้อมูลใน line application ของกลุ่มงานการพยาบาล การจัดเก็บใน Website ของโรงพยาบาล Google drive 3) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ หลังจากที่มีการถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร มีการประเมินผลโดยการนิเทศการปฏิบัติงาน การทบทวนเมื่อเกิดความเสี่ยง และการติดตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล และหน่วยงาน ด้านการจัดทำผลงานวิชาการ CQI นวัตกรรม	นวัตกรรม งานวิจัย ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เผยแพร่ในระบบเครือข่าย
หมวด 5 บุคลากร **5.1 ขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร** 1) ทีมผู้บริหารมีการกำหนดลักษณะงาน (Job description)และคุณลักษณะจำเพาะ (Job Specification) ของบุคลากรทุกตำแหน่ง ให้มีความชัดเจน สามารถนำมาต่อยอดสู่การเสริมสร้างสมรรถนะให้มีความเหมาะสมและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รองรับการพัฒนาขององค์กร มีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามระดับความรู้ความสามารถ จำแนกเป็น Common competency, Common functional competency และ Specific functional competency ผลการประเมินพบว่า บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 100% 2) มีการประเมินความเพียงพอของกำลังคนด้านการพยาบาลในแต่ละหน่วยงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อกระจายอัตรากำลังให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานเสนอความต้องการอัตรากำลัง กำหนดแนวทางให้เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล และงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีการกำหนดคุณสมบัติที่หน่วยงานต้องการ ผ่านกระบวนการสรรหา และคัดเลือก มีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงานตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้	1. Job description 2. Job specification 3. แบบประเมิน Competency 4. คู่มือจัดอัตรากำลัง 5. แผนพัฒนาบุคลากร 6. ผลการประเมิน Productivity 7. ข้อมูลประวัติบุคลากร 8. แผนพัฒนาบุคลากร

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
3) การวางแผนบุคลากร มีการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้มีความเพียงพอที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลโดยแผนระยะสั้น เป็นการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาระงานตามระบบการจำแนกประเภทผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยใช้เกณฑ์ Productivity เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา นอกจากนี้มีการวางแผนการจัดอัตรากำลังทดแทนบุคลากรที่เกษียณ และมีแผนโยกย้าย ส่วนแผนระยะยาวเป็นการวางแผนให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาวะโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่	
5.2 วัฒนธรรมองค์กรและการขับเคลื่อนความผูกพัน 1) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความผูกพันของบุคลากรในองค์กร พบว่า คะแนนความผูกพันต่อองค์กรในด้านการทุ่มเท ความพยายามในการปฏิบัติงานมีคะแนนสูงที่สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ด้านที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ความต้องการในการดำรงความเป็นสมาชิกขององค์กร ส่วนคะแนนสำรวจความพึงพอใจในงานบุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่าย 2) การตอบสนองต่อผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจในงาน ทีมผู้บริหาร จึงได้ทบทวน เรื่อง บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาระงาน การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การจ่ายค่าตอบแทน 1.5 เท่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบที่เหมาะสม เพิ่มช่องทางการหารายได้โดยการสร้าง line กลุ่มเพื่อจำหน่ายสินค้า 3) การสร้างวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรม Morning talk การประชุมประจำเดือน การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ และ Line application กลุ่มงานการพยาบาล ส่วนการกระตุ้นการสร้างผลงาน มีการมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการ การบริการที่ดีดุจญาติมิตร เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ การมีนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการนำเสนอในเวทีต่างๆ มีการยกย่องชมเชยผู้ที่ได้รับรางวัล หรือได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษสำหรับผู้มีผลงานเด่น เสียสละรับผิดชอบงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในองค์กร	1. ผลการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 2. การปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาล 3. ร่วมกิจกรรมโครงการองค์กรสร้างสุข 4. คำสั่งการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการพยาบาลตามวันหยุดเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
5.3 การประเมินความผูกพันของบุคลากร 1) การประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแบบเป็นทางการมีการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กร และแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพของกองการพยาบาล ส่วนการประเมินแบบไม่เป็นทางการมีการประเมินโดยการพูดคุย สอบถาม การสังเกต ขณะตรวจเยี่ยมตามหอผู้ป่วย 2) การนำผลการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาลไปใช้ในการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน การสร้างรายได้ สร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ของบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล/การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามลักษณะงาน การพิจารณาความก้าวหน้าและการเข้าสู่ตำแหน่งอย่างโปร่งใสตามหลักเกณฑ์/กำหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร (Career path) ของทุกระดับ/พิจารณาให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงอ้างอิงกับผลสัมฤทธิ์ของงาน ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาล 3) เมื่อประเมินความผูกพันของบุคลากรพยาบาลกับผลลัพธ์ของการบริการพยาบาล พบว่า ผลการประเมินความผูกพันและผลลัพธ์การบริการอยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย ทีมผู้บริหารจึงใช้กลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่อง มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน การจัดทรัพยากรที่เอื้อในการปฏิบัติงาน	1 .ผลการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 2. แนวปฏิบัติในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ
5.4 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 1) ระบบการประเมินผลงานบุคลากร ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจเกณฑ์การประเมิน โดยประเมินจาก Core competency เป้าหมายของงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติตาม Job description มีการให้คะแนนพิเศษ ในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การมีนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ การได้รับรางวัล คำชมเชย 2) ทีมผู้บริหารมีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นร่วมกันทุกตำแหน่งเพื่อให้บุคลากรทุกระดับทราบว่าตนเองต้องมีความสามารถในด้านใดบ้าง มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ เช่น ให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมสาขา	1. เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2. ผลการประเมิน Competency 3. ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมต่างๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
ต่างๆ ปฏิบัติงานในแผนกที่เชี่ยวชาญใช้เป็นข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และวางแผนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งต่างๆ 3) มีการนำผลการประเมินสมรรถนะมาสรุปผลเปรียบเทียบระหว่างสมรรถนะที่ต้องการกับผลการประเมินสมรรถนะที่ได้ นำส่วนขาดมาจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล หลังจากนั้นมีการประเมินซ้ำ เพื่อประเมินผลการพัฒนาให้มีความต่อเนื่อง	
5.5 การพัฒนาบุคลากรพยาบาลและผู้บริหารการพยาบาล 1) ผู้บริหารทางการพยาบาลเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลทุกคน และเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นและระดับกลาง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมแล้วจำนวน 3 คน อยู่ในแผนการอบรมจำนวน 2 คน ส่วนการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ กำหนดให้บุคลากรทุกคน ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 10 วันต่อคน/ปี มีการนำผลการประเมินสมรรถนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 2) การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของคณะกรรมการ HRM ในปีงบประมาณ 2566 ได้เพิ่มวิธีการประเมินเพื่อให้สามารถวัดประสิทธิผลของการอบรมและพัฒนาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดรูปแบบการอบรมพัฒนาบุคลากร โดยแยกประเภทการอบรมเป็น 3 ประเภท คือ 1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 2. อบรมทั่วไปที่ไม่ใช้งบประมาณ 3. อบรมที่ใช้งบประมาณ โดยการอบรมทุกครั้งบุคลากรจะต้องเขียนรายงานสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (HRM) ภายใน 1 เดือน และกำหนดแผนว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานในหน้าที่หรือการพัฒนาเป็นผลงานอย่างไรหลังจากนั้นมีการประเมินประสิทธิผลจากการพัฒนาผ่านระบบ HRM ซึ่งมีวิธีการประเมิน คือ -ประเมินการเรียนรู้ -ประเมินพฤติกรรม	1. แผนพัฒนาบุคลากร 2. ประวัติการอบรม 3. เอกสารการทำกิจกรรม KM 4. ผลการประเมิน Competency 5. การกำหนด Carrier path ขององค์กรพยาบาล 6. ภาพการร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
-ประเมินสัมฤทธิ์ผลจากการพัฒนา ส่วนเครื่องมือประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ ได้แก่ -แบบทดสอบ ก่อน-หลังการอบรม 2 -การให้นำเสนอการเรียนรู้โดยหัวหน้าเป็นผู้ประเมิน -การประเมินพฤติกรรม/การปฏิบัติหลังการอบรม -ผลงานเชิงพัฒนาเช่น นวัตกรรม คู่มือ งานวิจัย ต่างๆ 3) แนวทางในการจัดการเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลมีการกำกับ ติดตามให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติทำแบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นมีระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม มีเวทีให้บุคลากรสามารถนำเสนอผลงานในระดับอำเภอ จังหวัด และเขตบริการสุขภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเฉพาะทางในสาขาการพยาบาล เปิดโอกาสการทำงานร่วมกับทีมสุขภาพเชิงวิชาชีพในทีมคุณภาพของโรงพยาบาล ส่วนเส้นทางของการพัฒนาตามบันไดวิชาชีพพยาบาลสายบริหาร (Administration) มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้สนใจสร้างงานวิจัยต่อยอดเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ กำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหารที่สูงขึ้น เส้นทางสายปฏิบัติ (Clinical Nursing) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม ให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่รับผิดชอบ และเส้นทางสายวิจัย (Research) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้สนใจสร้างงานวิจัยต่อยอดเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ การส่งเสริมสุขภาพต่างๆ สวัสดิการด้านที่พัก ห้องออกกำลังกาย ห้องพระสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การลาต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้โรงพยาบาลมีการสร้างอาคารเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรได้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และรู้สึกผ่อนคลายในเวลาว่าง และการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรนอกสถานที่ปีละ 1 ครั้ง	
5.6 บรรยากาศในการทำงาน 1) มีนโยบาย Healthy Work Place เพื่อให้ที่ทำงาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา โดยขับเคลื่อนด้วยการทำกิจกรรม 5 ส ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีการสำรวจจุดเสี่ยงของหน่วยงานและดำเนินการแก้ไข การจัดพื้นที่	1. นโยบาย 2P safety 2. ผลการประเมินความเสี่ยงแผนกต่างๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
สำหรับพักผ่อนของบุคลากรในหน่วยงาน และแนวทางป้องกันภัยคุกคามจากเหตุความรุนแรงต่างๆ 2) การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทีมผู้บริหารให้การสนับสนุน สร้างความไว้วางใจ ให้กำลังใจบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ มีการนิเทศติดตามการดำเนินงาน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ มีการส่งเสริมการสร้างความรักสามัคคีในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความรักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หากพบปัญหาในการปฏิบัติงานมีการช่วยเหลือ และวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 3) การดูแลบุคลากรมีการจัดสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ สวัสดิการด้านที่พัก ห้องออกกำลังกาย ห้องพระสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การลาต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้โรงพยาบาลได้สร้างอาคารเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรได้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และรู้สึกผ่อนคลายในเวลาว่าง และการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรนอกสถานที่ปีละ 1 ครั้ง	3. ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 4. แฟ้มสุขภาพเจ้าหน้าที่ 5. ผลประเมิน Happinometer
5.7 สุขภาพของบุคลากร 1) มีนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety หรือ 2P Safety)มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่บุคลากรมีการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่มีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกแผนก ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร การมีส่วนร่วมใน Campaign ต่างๆ เช่น การสมัครก้าวท้าใจ 100% โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต 2) โรงพยาบาลและกลุ่มการพยาบาลมีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างเสริมสุขภาพเช่น วัฒนธรรมการไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัยการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การควบคุมระดับ BMI ให้อยู่ในเกณฑ์ มีการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดนโยบาย เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน	1. นโยบาย 2P safety 2. ผลการประเมินความเสี่ยงแผนกต่างๆ 3. ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 4. แฟ้มสุขภาพเจ้าหน้าที่

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
บุคลากรทุกคนมีการปฏิบัติตามนโยบายในการดูแลสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การควบคุม BMI การรับวัคซีนต่างๆ ส่วนนโยบายด้านอื่นที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัยโดยคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย การทิ้งขยะอย่างถูกต้อง การออกกำลังกาย เป็นต้น 3) บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี มีการบันทึกประวัติสุขภาพของบุคลากรทุกราย กรณีที่ได้รับอุบัติเหตุของมีคมทิ่ม ตำ หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง และมีการเจ็บป่วยและสงสัยว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ สามารถพบแพทย์และตรวจคัดกรองได้ทุกครั้ง	
หมวด 6 การปฏิบัติการบริการพยาบาล **6.1 ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร** 1) องค์กรพยาบาลมีการกำหนดกระบวนการหลักในการให้บริการตามพันธกิจขององค์กร ร่วมกับการศึกษาพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล เพื่อจัดบริการที่ตอบสนองต่อนโยบายขององค์กร มีการกำหนดกระบวนการหลักของบริการ ดังนี้ 1. การเตรียมการเข้ารับบริการ 2. การประเมินอาการและวินิจฉัยปัญหาผู้รับบริการ 3. การวางแผนก่อนการรักษาพยาบาล 4. การให้การรักษาพยาบาล 5. การประเมินผลการรักษาพยาบาล 6. การให้ข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัว 7. การวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง ส่วนหน่วยงาน เช่น OPD ANC หรือหน่วยงานที่จัดบริการพิเศษ เช่น คลินิก One Day surgery, คลินิกไตเทียม มีกระบวนการในการให้บริการ ดังนี้ 1. การพยาบาลก่อนตรวจ/ทำหัตถการ 2. การพยาบาลขณะตรวจ/ทำหัตถการ 3. การพยาบาลหลังตรวจ/ทัตถการ	1. Work instruction 2. ผลการนิเทศการใช้กระบวนการพยาบาล 3. ผลการนิเทศทางการพยาบาล 4. สรุปผลการประชุมทบทวนการดูแลผู้ป่วย

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
องค์กรพยาบาลได้กำหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อการจัดบริการที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 1. สมรรถนะด้านการให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน 2. สมรรถนะด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน 3. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพยาบาล 2) รูปแบบการจัดบริการพยาบาลขององค์กรพยาบาล ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการ การบริการ 4 มิติ ไว้ด้วยกัน คือการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ พยาบาลให้การดูแลเน้นการดูแลคนแบบองค์รวม (Holistic care) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย การให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยรูปแบบของระบบงานพยาบาลที่กำหนดขึ้นกับลักษณะงานของแผนกต่างๆ เช่น Team nursing Functional nursing และ Case management โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพการพยาบาล โดยส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing Conference) การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล (Nursing Rounds) ระบบการนิเทศ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และการกำหนดมาตรฐานการบันทึกทางการพยาบาล การจัดทำคู่มือปฏิบัติขององค์กรพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ และแนวทางปฏิบัติงาน (Wok Instruction: WI) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุม 3) วิธีการในการตัดสินใจเรื่องระบบงานที่สำคัญ คณะกรรมการบริหารองค์กรพยาบาลกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การบริหารอัตรากำลังงานห้องคลอดจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้จำนวนผู้คลอดลดลง การวางระบบการให้บริการ One Day Surgery การให้บริการผู้ป่วยตึกมินิธัญญารักษ์ โดยการใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence base) มาพัฒนาเป็น	

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
แนวทางปฏิบัติ โดยมีการประเมินผลการใช้แนวทางปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	
6.2 การออกแบบกระบวนการทำงาน 1) การกำหนดกระบวนการหลักในการให้บริการพยาบาลขององค์กรพยาบาลซึ่งสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักขององค์กรพยาบาลครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1. การเตรียมการเข้ารับบริการ 2. การประเมินอาการและวินิจฉัยปัญหาผู้รับบริการ 3. การวางแผนก่อนการรักษาพยาบาล 4. การให้การรักษาพยาบาล 5. การประเมินผลการรักษาพยาบาล 6. การให้ข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัว 7. การวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง 2) การระบุข้อกำหนดของกระบวนการทำงานที่สำคัญ มีการทบทวนพันธกิจและปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการทำงาน ได้แก่ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของภาระหน้าที่กำหนดไว้ ความสามารถของบุคลากร ความสามารถในการประเมินผล ความแตกต่างในความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3) องค์กรพยาบาลให้ความสำคัญกับการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ค่านิยม “SIRAT” มุ่งเน้นการบริการการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การให้การพยาบาลอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานวางระบบการกำกับ นิเทศการปฏิบัติตามมาตรฐานให้มีครอบคลุมกระบวนการทำงานที่กำหนด	1. แนวปฏิบัติทางการพยาบาล 2. ผลการทบทวนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง 3. ผลการตรวจสอบเวชระเบียน 4. ผลการนิเทศทางการพยาบาล 5. ผลผลิตทางการพยาบาล 6.ผลการประเมิน Commonและ Specific competency
6.3 การจัดการกระบวนการทำงาน 1) การติดตามกำกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงานที่สำคัญให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ มีขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร หน่วยงาน และตัวชี้วัดระดับบุคคล กำหนดวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดให้ส่งรายงานตัวชี้วัดทุก 1 เดือน เพื่อนำข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	1. ผลการนิเทศงาน 2. รายงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
นำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้บริหารการพยาบาลมีการนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่บุคลากร นำผลการนิเทศทางการพยาบาลมาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล 2) การกำหนดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพทางการพยาบาล จำนวน 35 ตัวชี้วัด จำแนกเป็น -ผลลัพธ์ด้านการบริการพยาบาล 10 ตัวชี้วัด -ผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ 7 ตัวชี้วัด -ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 5 ตัวชี้วัด -ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 6 ตัวชี้วัด -ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ 3 ตัวชี้วัด -ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร 4 ตัวชี้วัด 3) ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญกับคุณภาพของผลงาน การจัดกลุ่มตัวชี้วัดในมิติต่างๆ เพื่อประเมินคุณภาพการพยาบาลในแต่ละด้าน มีความครอบคลุมทุกมิติของการให้บริการพยาบาล เมื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดมีการรายงานผลการดำเนินงาน ทีมบริหารองค์กรพยาบาลมีการประเมินคุณภาพการพยาบาลในมิติต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน มีการเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญกับโรงพยาบาลปรางค์กู่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่เทียบที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	
6.4 การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 1) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลงาน ผลการดำเนินการและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความเชี่ยวชาญพิเศษของกลุ่มงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบกระบวนการสำคัญ ทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีแนวทางการรายงานผู้เกี่ยวข้องเมื่อผู้ปฏิบัติงานพบปัญหาขณะปฏิบัติงาน การนิเทศโดยหัวหน้าทีม หัวหน้างาน และหัวหน้าพยาบาล มีการทบทวนหาโอกาสพัฒนาโดยวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน การทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับ	1. รายงานตัวชี้วัด 2. ผลการทบทวนอุบัติการณ์ 3. แผนพัฒนาบุคลากร 4. ผลงาน CQI นวัตกรรม

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
เป้าหมายที่กหนดไว้ มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบริการพิเศษ ได้แก่ One day surgery การเตรียมเปิดบริการผ่าตัด Pterigium 2) การทบทวนตัวชี้วัดผลการดำเนินการ เพื่อยกระดับผลงาน ผลการดำเนินงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความเชี่ยวชาญพิเศษของกลุ่มงาน มีการทบทวนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัดกับโรงพยาบาลคู่เทียบ เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาปรับปรุงการดำเนินการขององค์กรให้ดีขึ้น 3) การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการใช้กระบวนการคุณภาพ มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน นำประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายมาวางแผนพัฒนา มีการใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนางาน มีกิจกรรมการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย มีการนำแผนดำเนินงานเชื่อมโยงกับระบบการนิเทศงาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับรวมทั้ง มีการเฝ้าระวังและรายงานผลลัพธ์การดูแลทุกเดือน	
6.5 การจัดการนวัตกรรม 1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานโดยใช้การจัดการความรู้ มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการ CQI วิจัยทางการพยาบาล หรือนวัตกรรม อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับจังหวัด 2 มีการจัดสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลทุกหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ป้ายชี้บ่งประเภทผู้ป่วยของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ทรัพยากรที่จัดหาได้ในหน่วยงาน 3) โรงพยาบาลมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมต่างๆ โดยสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับจังหวัด และระดับต่างๆ โดยอำนวยความสะดวก งบประมาณสนับสนุน	1. ผลการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานระหว่างโรงพยาบาลระดับเดียวกัน 2. ผลงานวิชาการ นวัตกรรม CQI
6.6 การยึดหลักการพยาบาลองค์รวมและกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล	

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
1) องค์กรพยาบาลมุ่งเน้นให้บุคลากรยึดหลักการพยาบาลองค์รวม ตามพันธกิจขององค์กร มอบหมายหัวหน้างานถ่ายทอดนโยบาย ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด การใช้กระบวนการพยาบาลโดยการประเมินสภาพ รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล มีการวางแผนปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผลการปฏิบัติให้มีความครอบคลุม ทั้งระดับบุคคลครอบครัว และชุมชน โดยการประสานความร่วมมือในทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย โภชนากร พยาบาลเยี่ยมบ้าน เพื่อดูแลผู้ป่วยและให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติ โดยให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจในการวางแผนการรักษา 2) ปฏิบัติการพยาบาลอย่างถูกต้องโดยใช้ศาสตร์และศิลป์แห่งวิชาชีพ ตามมาตรฐานการพยาบาล ตอบสนอง ปัญหา/ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการปฏิบัติการพยาบาลที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัย พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติการพยาบาลมีการตรวจสอบความถูกต้องในการระบุตัวผู้ป่วย การบริหารยาด้วยความถูกต้อง การทำหัตถการต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพ มีการเฝ้าระวังความปอดภัยของผู้ป่วยตลอดเวลาที่อยู่ในความดูแล 3) ปฏิบัติการพยาบาลโดยมีการ ประสานความร่วมมือในทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเน้นการใช้ครอบคลุมทุกกระบวนการพยาบาล 3) การทำงานร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพตั้งแต่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลและการดูแลต่อเนื่องเมื่อกลับสู่ชุมชน มีการจัดทำแนวทางการประสานงานกับวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วย แนวทางการสื่อสารผ่านการบันทึกปัญหาและข้อมูลในเวชระเบียน มีการประชุมทบทวนร่วมกันโดยทีมนำทางคลินิก (PCT) เพื่อแก้ปัญหาและหาโอกาสพัฒนาร่วมกัน มีการกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในชุมชนผ่านศูนย์ COC	1. การตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียน 2. แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลการเยี่ยมบ้านสู่ชุมชน 3.แบบประเมินผู้ป่วยรายโรคที่สำคัญ
6.7 การจัดการอาการรบกวน การช่วยให้ผู้ป่วยบรรเทา จากความเจ็บปวด/ความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 1) องค์กรพยาบาลมีนโยบายให้การประเมินความปวดเป็น Fifth Vital Signs มีการจัดแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความปวด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากร โดยกำหนดให้พยาบาลมีบทบาทในการดูแลเพื่อตอบสนองความ	แนวปฏิบัติการจัดการความปวด

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
ต้องการทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มีเป้าหมายเพื่อการบรรเทาอาการหรือหยุดยั้งความทุกข์ทรมาน การช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 2) มีการบันทึกข้อมูลการจัดการความปวดของผู้รับบริการ ได้แก่ Pain score, ข้อมูลการให้ยา ข้อมูลการพยาบาล และข้อมูลการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงขณะได้รับยา มีคณะกรรมการรวบรวมเป็นผู้รวบรวมข้อมูล นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล 3) มีการทบทวนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความปวดในระดับต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน	
6.8 การจัดบริการพยาบาลที่มีความปลอดภัย ปราศจาก ภาวะแทรกซ้อน ที่ป้องกันได้ทั้งด้านร่างกายจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 1) มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน มีการสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ -Patient and Personnel Safety (2P Safety) และมาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ข้อ -แนวทางปฏิบัติในการประเมินและป้องกันการ เกิดแผลกดทับ โดยใช้ Barden score -แนวทางการป้องกันการตกเตียงโดยใช้ MORSE FALL Risk -แนวทางการใช้ยากลุ่มเสี่ยงสูง (HAD) -แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล เช่น การป้องกันการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ Hand Hygiene การป้องกันการเกิด Sharp Injury การสวมใส่ PPE การแยกขยะประเภทต่างๆ การปฏิบัติตามหลักการ Isolation Precautions เป็นต้น 2) มีการบันทึกและรายงานความเสี่ยง โดยใช้โปรแกรมรายงานความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานความเสี่ยงอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อเดือน หัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบในการยืนยันและทบทวนความเสี่ยงเบื้องต้น การส่งรายงานความเสี่ยงไปยังหน่วยงานและทีม	1. นโยบาย 2P Safety 2. การรายงานอุบัติการณ์- 3. ผลการทบทวนอุบัติการณ์

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง มีการประมวลผลรายงานเพื่อทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในท่ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน กรณีความเสี่ยงที่รุนแรงสูงระดับ G H I ต้องรายงานหัวหน้าพยาบาลให้ทราบ และทบทวนเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง 3) การทบทวนการป้องกันภาวะแทรกซ้อน และกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ โดยกำหนดให้มีการทบทวนอุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไป โดยใช้กระบวนการ RCA ในระดับหน่วยงาน และระดับทีม การสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ	
6.9 การทบทวนกระบวนการดูแลผู้ใช้บริการ 1) นโยบายและแผนการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ใช้บริการ มีการกำหนดนโยบายในการรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การปฏิบัติตามนโยบาย 2P safety การใช้ Early Warning signs และแนวทางการจัดการความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน เมื่อพบปัญหาหรืออุบัติการณ์เกี่ยวกับผู้รับบริการหน่วยงานที่พบเหตุการณ์มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หลังจากนั้นจึงดำเนินการทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อวางแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ 2) การรายงานผลการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย มีการจัดทำรายงานทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย จัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน และบันทึกข้อมูลในระบบรายงานความเสี่ยงในระบบ Healthcare Risk Management System มีระบบการเชื่อมโยงรายงานไปยังหน่วยงานต่าง เพื่อการทบทวนและแก้ไขอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น 3) การนำผลการทบทวนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลโดยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงาน โดยทีมนำทางคลินิกมีการนำผลการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย ผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตาม CPG มาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยทางคลินิกที่ตรงประเด็น	ผลการทบทวนการดูแลผู้ป่วย และการทบทวนอุบัติการณ์
6.10 การดูแลต่อเนื่อง 1) มีระบบและแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยประคับประคอง โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน พยาบาลPaliative (PM) จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง	1. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่อง 2. ผลการประชุมทีม COC

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
Advance Care Plan ในกลุ่มผู้ป่วยPaliative โดยการส่งต่อข้อมูลไปยังศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) และรพ.สต.โดยผ่านช่องทาง line การโทรศัพท์และการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม Thai care cloud และมีศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น 2) เมื่อมีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยไปยังศูนย์เยี่ยมบ้านแล้ว ทีมเยี่ยมบ้านจะเตรียมข้อมูลในการเยี่ยมต่อเนื่องร่วมกับรพ.สต. นัดหมายการปฏิบัติงาน มีการลงบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านในระบบ 3) มีของฝากเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และจากวัด ที่ได้รับบริจาคอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือและเสริมพลังให้ผู้ป่วย 4) มีการประเมินผลการติดตามดูแลต่อเนื่องโดยทีมเยี่ยมบ้าน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และร่วมกันในการวางแผนแก้ไขปัญหา มีการจัดประชุมทุก 3 เดือน	3. Advance Care Plan
6.11 การส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ใช้บริการ 1) ระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย มีการกำหนดให้มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโดยใช้หลัก DMETHOD เริ่มการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่รับผู้ป่วยไว้ในการดูแล โดยทีมสหวิชาชีพร่วมกันอย่างเป็นทีมโดยเฉพาะการวางแผนการตัดสินใจในแนวทางการรักษาและการดูแลตนเอง เน้นการดูแลแบบองค์รวม และมีการสื่อสารระหว่างทีมงานที่ชัดเจนเพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ป่วยในการใช้ชีวิตที่บ้าน 2) ผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการจะได้รับการวางแผนการดูแลและผู้ป่วยที่มีปัญหาในการดูแลรักษาจะได้รับการวางแผนก่อนจำหน่ายตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกไปใช้ในการวางแผน มีการใช้สื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เอกสาร วิดีทัศน์ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวหลังจำหน่าย 3) ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่อง มีการเสริมพลังทั้งผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และส่งต่อข้อมูลให้ทีมเยี่ยมบ้าน เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่เหมาะสม และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อไป	แนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายผู้ป่วย
6.12 การบันทึกการพยาบาล	

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
1) มีการกำหนดแนวทางการบันทึกทางการพยาบาลโดยบันทึกในโปรแกรม HOSxP มีการกำหนดแนวทางการบันทึกทางการพยาบาลครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญ 4 ประเด็น ดังนี้ -การใช้กระบวนการพยาบาล -การพยาบาลแบบองค์รวม -การบันทึกตามหลัก 4 C (Correct Cmplete Clear Concise) -การวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่องเพียงพอต่อการเป็นหลักฐานทางกฎหมาย มีการกำกับติดตามคุณภาพการบันทึกโดยกำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล 2) การบันทึกทางการพยาบาลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างแผนก และทีมสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ สามารถนำข้อบกพร่องที่พบ มาพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย และพัฒนาสมรรถะบุคลากร 3) การบันทึกทางการพยาบาลที่บันทึกในโปรแกรม HOSxP มีระบบความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ มีการระบุวัน เวลา และชื่อผู้บันทึกอย่างครบถ้วน มีการกำหนดมาตรฐานการบันทึกของแต่ละแผนกที่สะท้อนการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย	1. แนวทางปฏิบัติในการบันทึกทางการพยาบาล 2. ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
หมวด 6 การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล **6.1 ระบบงานและความเชี่ยวชาญพิเศษ** 1) เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทางกลุ่มงานได้กำหนดระบบงาน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการติดเชื้อให้ต่ำที่สุด เจ้าหน้าที่ไม่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมไม่เสี่ยงการติดเชื้อและความเชี่ยวชาญพิเศษ คือ การแยกโรคในผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อต่างๆตลอดทั้งการแยกโซนผู้ป่วย งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 12 คน โดยมีแพทย์เป็นประธานคณะกรรมการพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (ICN) 1 คนซึ่งทำงาน Full time และรับผิดชอบงานจ่ายกลาง งานซักฟอกเป็นเลขาทีม มี ICWN 6 คนจากทุก	1. Service profile 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3. คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 4. แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 5. บันทึกการประชุมคณะกรรมการ IC

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
หน่วยงานเป็นคณะกรรมการและ ICWN จากหน่วยงานหลักเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย - ตึกผู้ป่วยในชาย - ตึกผู้ป่วยในหญิง - งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน - งานห้องคลอด - งานผู้ป่วยนอก คลินิกโรคเรื้อรัง - หน่วยจ่ายกลาง - ตึกแสงอรุณ - กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ หน้าที่หลักได้แก่การบริหารจัดการและติดตามกำกับระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การสอบสวนและการควบคุมการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล/โรคติดเชื้อรุนแรง อุบัติใหม่อุบัติซ้ำ การพัฒนาความรู้ทักษะและให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่บุคลากรทางการพยาบาลการดูแลต่อเนื่อง การคุ้มครองภาวะสุขภาพการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยร่วมทั้งการบันทึกทางการพยาบาลซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 2) เพื่อให้ความเชื่อมโยงกันของระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายผู้รับบริการติดเชื้อต่ำสุด เจ้าหน้าที่ไม่ติดเชื้อ ภายใต้หลักคิด “ปลอดภัย” ได้ออกแบบการทำงานการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นคณะกรรมการเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆ มีการนำเสนอข้อมูลย้อนกลับในการประชุมคณะกรรมการ IC คณะกรรมการบริหาร ผลการดำเนินการในปี 2566 พบการติดเชื้อตำแหน่งการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำระดับ 3 1 ราย ภายหลังการทบทวนปี 2567 ยังพบปัญหาการเกิด Phlebitis 1 รายจากยาความเข้มข้นสูงได้มีการทบทวน หลังทบทวนยังไม่พบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น	

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
3) เพื่อช่วยให้องค์กรพยาบาลบรรลุพันธกิจ ทางกลุ่มงานโดยการทำงานเชื่อมประสานสหวิชาชีพได้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ เช่น การบริหารจัดการด้านสถานที่โดยใช้ห้องพิเศษ เพื่อใช้เป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ำ ในช่วงระบาด COVID-19 ได้ใช้ตึกผู้ป่วยในหญิงเป็น Cohort ward และปัจจุบันจัดให้มีห้องแยกโรคติดเชื้อ 2 ห้อง และมีห้องแยกผู้ป่วยวัณโรคช่วงระยะแพร่กระจายเชื้อโดยเฉพาะ	
6.2 การออกแบบกระบวนการทำงาน 1) มีการกำหนดกิจกรรมสำคัญในงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล -การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล -การแยกผู้ป่วย(Isolation precautions) -การทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ(Disinfection,sterilization) -การดูแลสุขภาพบุคลากร(employee health) -การดูแลผู้ป่วย(patient care) -การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(microbiological service) -การให้ความรู้แก่บุคลากร(education and training) -การควบคุมสิ่งแวดล้อม(environment control) -การประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในชุมชน (Community coordination) -การวิจัย(reseach) ผลการดำเนินงาน พบว่า กลุ่มโรคที่ให้ความสำคัญมีการเน้น Isolate-hand hygiene ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและร่วมกับพยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในการเฝ้าระวังไข้เลือดออกเน้นการตัดวงจรยุงลายความสะอาดของบ้านเรือนร่วมกับทีมควบคุมโรค 2) ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 1. เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นแบบ Targeted surveillance ได้แก่ SSI CAUTI HAP เชื้อดื้อยา ตาและสะดือแฉะในทารกแรกเกิด แผลฝีเย็บติดเชื้อที่แผลกดทับ	ระเบียบปฏิบัติบัติสำคัญเช่น -การล้างมือ - CAUTI -Phebitis

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
2. การแยกผู้ป่วย ผู้ป่วยนอกแยกกลุ่ม Airborne precaution Droplet precaution Contraction precaution 3. การทำลายเชื้อทำให้ปราศจากเชื้อ มีการล้างเครื่องมือศูนย์กลางที่หน่วยจ่ายกลาง 4. การดูแลบุคลากรเน้นการป้องกันเข็มทิ่มตำและสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา การได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนCOVID - 19 5. การดูแลผู้ป่วยเน้นการ Isolate ทุกจุดบริการ 6. การตรวจทางห้องปฏิบัติการในการติดตามดูผลการเพาะเชื้อซึ่งโรงพยาบาลส่งกรุงเทพมหานคร อาจมีความล่าช้าแต่ในส่วนการรักษามีการให้ยาฆ่าเชื้อไปก่อน และเคสไหนสงสัยติดเชื้อดื้อยาให้แยกตามมาตรการดื้อยา 7. ในส่วนของการให้ความรู้ เน้นการป้องกันตนเองตามช่องทางติดต่อและการล้างมือ มีการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน การประชุมวิชาการปีละ 1 ครั้ง 8. ส่วนของการควบคุมสิ่งแวดล้อมกำหนดน้ำดื่มน้ำใช้น้ำเสียตรวจทุก 4-6 เดือน 9. การประสานงานกับทีมชุมชนมีคณะกรรมการ IPC เป็นทีมของ ICC1 คนเป็นผู้เชื่อมประสาน 10. ส่วนของงานวิจัยกำหนดให้อย่างน้อยต้องมีผลงานวิชาการเป็นCQI ก็ได้นำเสนอแลกเปลี่ยนภายในระดับจังหวัด 3) จากการดำเนินการผ่านมา ผลงานที่มอบให้ผู้รับบริการพบว่าอัตราการติดเชื้อลดลง เจ้าหน้าที่ไม่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ผลน้ำดื่มผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ผลตรวจน้ำเสียพบว่ามีค่าตรวจน้ำไม่ผ่านเกณฑ์จากผลการทบทวนพบว่า มีการขยายตึกนอนผู้ป่วยทำให้บ่อเดิมรองรับปริมาณน้ำไม่เพียงพอได้มีแผนแก้ไขปรับปรุง	
6.3 การจัดการกระบวนการทำงาน 1) เพื่อให้การจัดการกระบวนการมีประสิทธิภาพงานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลและองค์กรพยาบาล นำแผนยุทธศาสตร์หลักมาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีกำหนดจุดเน้นการปฏิบัติแต่ละปี	1. ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปี 2564 - 2567

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
2) กำหนดตัวชี้วัดหลักมีการถ่ายทอดและการสื่อสารแผนผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและบุคลากรโดยตรงทั้งแบบทางเดียวและสองทางจัดทำตารางกำกับแผนการดำเนินงานเป็นรายเดือนมีการส่งประเมินการปฏิบัติและมีการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานรวมทั้งมีการประชุมวิชาการอบรมฟื้นฟูวิชาการลงหน้างาน 3) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุกเดือนมีการทบทวนและประเมินแผนและปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย วางแผนนโดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCAอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การดำเนินงานปี 2566 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 0.09 ครั้ง/1,000 วันนอนตำแหน่ง Phlebitis	2. รายงานการสอบสวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3. แผนนิเทศกำกับติดตามงาน 4. แผนงานโครงการ 5. ข้อมูลสรุปการ Round ในหน่วยงาน
6.4 การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 1) เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องงานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อมีการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุกเดือนมีการติดตามเฝ้าระวังอุบัติการณ์ การติดเชื้อและอุบัติการณ์ ความเสี่ยงทางการติดเชื้อ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการทุกเดือนมีการทบทวนทุกครั้งที่พบอุบัติการณ์มีการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายวางแผนงานโดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA มีการติดตามและทบทวนตัวชี้วัดสม่ำเสมอโดยการประชุมคณะกรรมการ IPC มีทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีม PCT จัดการด้านความรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งทำกิจกรรม IC Round ร่วมกับทีม ENV เพื่อค้นหาและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและได้มีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อการบริการพยาบาล 2) มีการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายวางแผนโดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA มีการติดตามและทบทวนตัวชี้วัดสม่ำเสมอโดยการประชุมคณะกรรมการ IPC การทบทวนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีม PCT ร่วมกับ IC Round ร่วมกับทีม ENV เพื่อค้นหาและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและได้มีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อการบริการการพยาบาล ตัวอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมา อุบัติเหตุเข็มทิ่มเจ้าหน้าที่พบทุกปีทีมได้ทบทวน	1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2564-2567 2. โครงการ 2P safety และซ้อมแผน COVID-19

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
และหาสาเหตุพร้อมนำเสนอผู้บริหารในการขออนุมัติซื้อวัสดุที่ลดการทิ่มตำ เช่น กล่องทิ้งเข็ม Three-way drip ยาทางหลอดเลือดดำ อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เช่น แว่นตา Face shied พบว่าอุบัติการณ์ลดลง 3) จากการทบทวนปรับปรุง มีผลงาน CQI เช่น แผลฝีเย็บมารดาหลังคลอด SHIP หยุดแพร่กระจายเชื้อดื้อยา Bundle CAUTI การเฝ้าระวัง HAP ในผู้ป่วย การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อช่วง COVID – 19 และหลังสถานการณ์กล่องทิ้งเข็ม Three-way drip ยาทางหลอดเลือดดำ อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เช่น แว่นตา Face shied พบว่าอุบัติการณ์ลดลง	
6.5 การจัดการนวัตกรรม 1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อนำวิชาการสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมจัดทำแนวทางปฏิบัติโดยทดลองปฏิบัติประเมินผลการปฏิบัติและกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล มีการใช้ Bundle การดูแลผู้ป่วยใส่คาสายสวนปัสสาวะเพื่อลดการติดเชื้อ CAUTI ส่งบุคลากรทางการพยาบาล เข้ารับการประชุมวิชาการประจำปี การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำมาถ่ายทอดในที่ประชุมหน่วยงานทบทวนระเบียบปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติและเอกสารอ้างอิงให้ทันสมัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประกวดผลงานวิชาการระดับโรงพยาบาลและจังหวัดมีการนำหลักการเรียนมาใช้ มีการพัฒนาคุณภาพในงานจ่ายกลางนำโปรแกรมมาใช้ 2) การป้องกันการติดเชื้อที่ตาสะดือทารกแรกเกิด แผลฝีเย็บมารดาหลังคลอด SHIP หยุดแพร่กระจายเชื้อดื้อยา Bundle CAUTI การเฝ้าระวัง HAP ในหอผู้ป่วยปิดผนึกซองซิลป้องกันของมีคมแทงทะลุ 3) สนับสนุนให้องค์กรพยาบาลได้มีนวัตกรรมผู้รับผิดชอบงานวิชาการจัดทำโครงการสร้างสรรค์งานวิชาการร่วมกับโรงพยาบาลและเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอเรียนรู้นอกองค์กรเกิดผลงานที่ใช้ในการทำงานได้จริงจนถึงปัจจุบัน	นวัตกรรม -การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใส่คาสายสวนปัสสาวะ -การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ -การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
6.6 การลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 1) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้มีการวางระบบการป้องกันและควบคุมการติด	ผลการนิเทศติดตาม รพ.สต. ติดดาว 8 แห่ง

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
เชื้อในโรงพยาบาลครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยตั้งแต่งานบริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอดจนงานสนับสนุนต่างๆโดยให้หน่วยงานจัดแบ่งพื้นที่โซนนิ่งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อการกำหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยหรือของสกปรก -จัดให้มีอ่างล้างมือสบู่เหลวและน้ำยาล้างมือผ้าเช็ดมือให้เพียงพอ -การปรับระบบจ่ายกลางให้เป็นศูนย์กลางของการล้างเครื่องมือและทำปราศเชื้อ CSSD -มีการปรับปรุงหน่วยงานซักฟอก -มีการปรับปรุงอาคารโรงครัว -มีการปรับปรุงห้องแยกที่ชัดเจน มีห้อง AIIR ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยในหญิง -มีการแยกzone ตึกสงฆ์แยกผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ การแยกโซนสำหรับผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อในห้อง single room และห้องแยกผู้ป่วยวัณโรค -งานผู้ป่วยนอกมีการแยกโซนคัดกรองและการตรวจรับผู้ป่วยแบบ one stop service สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเช่นวัณโรค โควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ -มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ตามแนวทางหลักการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เป็นแม่บ้าน คนงาน แต่มีการอบรมให้ความรู้โดยงาน IPC 2) มีการอำนวยความสะดวกในการล้างมือทั้งแบบใช้น้ำและไม่ใช้น้ำโดยมีอ่างล้างมือในจุดบริการตลอดทั้งติดตั้งขวดแอลกอฮอล์เจลทุกเตียงทุกจุดบริการเน้นการแยกโซนในทุกหน่วยงาน 3) มีแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการทำลายเชื้อทำให้ปราศจากเชื้อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและประเมินผลปฏิบัติพบโอกาสพัฒนาเรื่องการสวมชุด PPE ไม่ครบ มีของมีคมในมูลฝอยหลังดำเนินการไม่พบอุบัติการณ์ส่วนการล้างมือรณรงค์ประจำทุกปีอัตราการล้างมือครบ 5 moment เพิ่มขึ้น	-คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามหลัก Standard Precaution -สรุปผลการนิเทศติดตามหน่วยงาน

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
6.7 การลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในองค์กร 1) องค์กรพยาบาลได้มีการวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อดังนี้ 1. กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อซึ่งติดต่อได้ทางโลหิตผู้ป่วย HIV ทุกคนที่ขึ้นทะเบียนรักษาคลินิก โดยคลินิกเพื่อนในกลุ่มงานปฐมภูมิเป็นผู้รับผิดชอบติดตามการดูแลรักษากรณีผู้ป่วยตั้งครรภ์ประสานกับงาน ANC ส่วนผู้คลอดประสานกับงานห้องคลอดเพื่อให้ยาต่อเนื่องตามแผนการรักษา 2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้านทานต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ ให้อยู่ห้องแยกพิเศษตึกสงฆ์อาพาธ และมีบริการแอลกอฮอล์เจล ติดไว้ที่ปลายเตียงทุกเตียงหรือก่อนเข้าห้องพิเศษ 3. กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่รับรักษาต่อจากโรงพยาบาลศรีสะเกษเพื่อมาฉีดยา Antibioticต่อ ได้มีการแยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยกลุ่มอื่นโดยการเข้าห้องแยกหรือแยกโซนการดูแลรักษาตามแนวทางที่กำหนดและมีการบริการแอลกอฮอล์เจล ติดไว้ที่ปลายเตียงทุกเตียงเน้นการล้างมือก่อนและหลังการดูแลคนไข้ แยกของใช้ต่างๆ และทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาคุณภาพเรื่องรูปแบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน 4. มีแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการสวมอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง จากการระบาดของcovid - 19 ที่ผ่านมาได้มีการซ้อมและถอดบทเรียนสถานการณ์ผู้ป่วยจริง สงสัยและได้ส่งต่อพบว่ายังติดขัดในเรื่องของการประสานเส้นทางและข้อจำกัดของการใช้รถส่งต่อภายหลังได้ถอดบทเรียนและปรับปรุงใหม่ในสถานการณ์การระบาดจริงปี 2564 พบการใช้อุปกรณ์ป้องกันไม่เหมาะสมและไม่ปฏิบัติตาม standard ไม่สวม face shield ภายหลังการทบทวนไม่พบอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการทำงาน 2) มีการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะในพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ขึ้นเน้นการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติและเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อลดอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะการปรับเปลี่ยนการใช้เจลหล่อลื่นเป็นแบบใช้ครั้ง	แนวทางปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วย

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
เดียวทิ้งและลดการใส่สายเปลี่ยนเป็น External cath ในผู้ป่วยชาย ผลการดำเนินการที่ผ่านมาปี 2566 พบ Phlebitis 1 ราย คิดอัตราการติดเชื้อ 0.9 3) มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติและจัดอุปกรณ์สถานที่โดยเน้นการแยกผู้ป่วยและสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้เพียงพอและเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเช่นการแยกโรคในผู้ป่วยนอกจะทำอ่างล้างมือและสนับสนุนเจลล้างมือในทุกจุดบริการ	
6.8 การเฝ้าระวัง ติดตามกำกับและควบคุมการระบาด 1) การเฝ้าระวังผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการ เฝ้าระวังแบบ Hospital Wide Target surveillance - มีการทำ point prevalence survey ปีละ 1 ครั้ง มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบ targeted surveillance ในตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ CAUTI, แผลฝีเย็บ, Phlebitis เป็นต้น โดยมีพยาบาลประจำการในหอผู้ป่วยเฝ้าระวังแบบ passive surveillance และมี ICWN ประสานงานกับ ICN ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและรวบรวมข้อมูล แบบฟอร์มรายงาน และวิธีการรายงานมีการรายงาน ICN ทันทีเมื่อเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดย ICN, ICWN และวางแผนพัฒนาให้ RN ทุกคนสามารถทำการเฝ้าระวังการติดเชื้อได้ เพื่อลดการ under report และให้ได้ข้อมูลที่ทันเวลา ครบถ้วน และได้มีการฟื้นฟูสอน แผนพัฒนาให้ RN ทุกคนสามารถทำการเฝ้าระวังการติดเชื้อได้ เพื่อลดการ under report และให้ได้ข้อมูลที่ทันเวลา ครบถ้วน และได้มีการฟื้นฟูสอนทบทวน การเฝ้าระวังการติดเชื้อสำหรับ ICWN 100% และติดตามทดสอบความรู้ร่วมกับการสำรวจประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อ 2) มีการเก็บข้อมูลจากตัวชี้วัดรายงานเดือนของงานและใช้ข้อมูลจากรายงาน 506 ในส่วนการเฝ้าระวังด้านชุมชนโดยการกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังโรคในชุมชนได้แก่โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง โรคมือเท้าปาก ร่วมกับ งานระบาดวิทยามีการรณรงค์ให้ความรู้ในโรงเรียนและสอนการล้างมือที่ถูกต้องมีการวางระบบและการสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจากระบบโรงพยาบาลจนถึงชุมชนโดยผ่านเจ้าหน้าที่รพสตร่วมกับ COC เพิ่มการอบรม อสม. ร่วมกับทีม SRRT ในการซ้อมแผนรับมือโรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้องานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานทีมนำและ	ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อปี 2564-2567 -แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดในโรงพยาบาล -รายงานการสอบสวนการระบาดปี 2564-2567

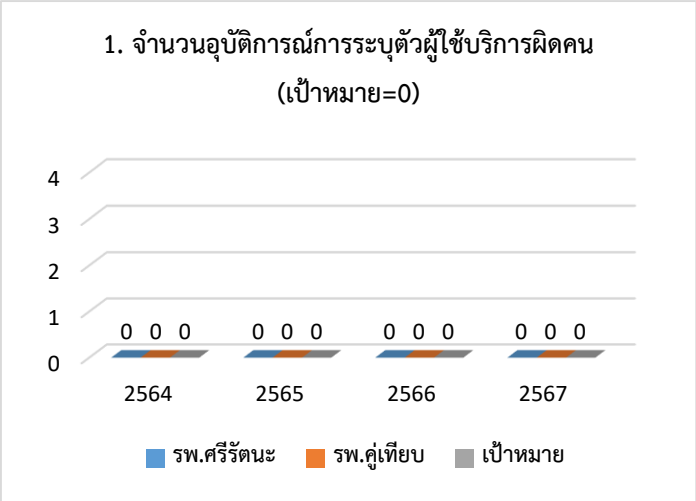
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
รายงานคุณภาพ กำหนดให้อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลและระดับองค์กรพยาบาล IPC วิเคราะห์ข้อมูลติดตามแก้ไขการติดเชื้อรวบรวมข้อมูลส่งระบบ ระบบ RM รายงานความเสี่ยงตามโปรแกรม IPC ให้ทีม ICC ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแก้ไขและป้องกัน 3) การควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำมีแนวทางที่กำหนดชัดเจนทั้งภายในและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล มีการซ้อมแผนเสมือนจริงในการรับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ในโรงพยาบาล ดำเนินการออกแบบและวางแผนการจัดการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและรพ.สต.ตลอดจนในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในช่วงวิกฤต Covid-19 ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน (active finding case) เพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่ และให้ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โรคติดเชื้อในชุมชน เกิดการสื่อสารที่ตรงกัน จากสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 อำเภอศรีรัตนะที่ผ่านมา พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ตำบลตูมจำนวน 13 ราย ทีมคณะกรรมการ EOC อำเภอศรีรัตนะได้ประชุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทันที หลังจากพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน หลังจากพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม สอบสวนโรค รักษาผู้ป่วย โดยแยกกักตัวและรักษาในศูนย์พักคอย (Community Isolation) กลุ่มที่ไม่มีอาการ กลุ่มที่มีอาการเข้าโรงพยาบาลสนามและCohort ward ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโควิด19 และการติดตามค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อตรวจหาเชื้อได้ครอบคลุม	

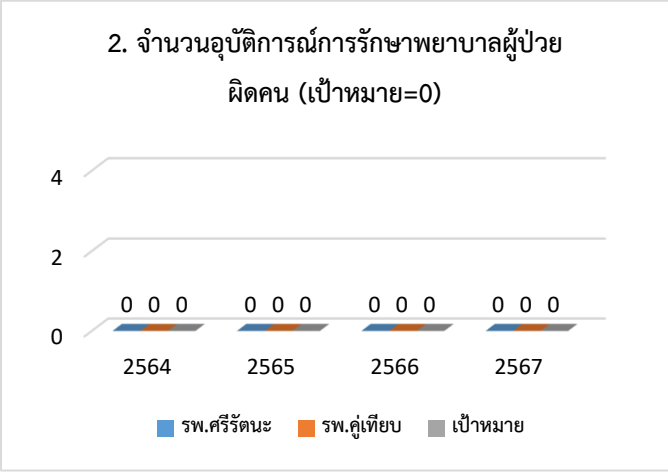
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ
6.9 การปฏิบัติการในหน่วยจ่ายกลาง 1) หน่วยจ่ายกลางโรงพยาบาลศรีรัตนะพัฒนาเป็นศูนย์จ่ายกลาง มีอาคารสถานที่ชัดเจนแยกเฉพาะและมีการออกแบบพื้นที่ตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง ประกอบด้วย Zone สกปรก Zone สะอาดและจัดการสัญจรเป็นแบบ One way มีหน้าที่รวบรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วนำมาเข้าสู่กระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ มีเจตจำนง คือให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สะอาดปราศจากเชื้อ เพียงพอและพร้อมใช้ 2) อัตรากำลังของหน่วยจ่ายกลางทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 1 คนผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง IC 4 เดือน เป็นหัวหน้างานซึ่งรับผิดชอบงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและจ่ายกลาง มีลูกจ้างประจำ 4 คน มีการจัดอัตรากำลังโดย วันเวลาราชการ จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 4 คน วันเสาร์ วันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2 คน และวันหยุดนักขัตฤกษ์จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3 คน ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการในเวลา 08.00 – 16.00 น. อุปกรณ์เครื่องมือที่สำคัญในหน่วยงาน ได้แก่ เครื่องนึ่งไอน้ำชนิดแทนที่อากาศ 2 เครื่อง เครื่องอบแห้งสายยาง 1 เครื่องเครื่องอบแก๊ส และเครื่องอุ่นเชื้อ 1 เครื่อง เครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ 1 เครื่อง ผู้รับบริการของงานจ่ายกลาง ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลศรีรัตนะ ศูนย์สุขภาพชุมชน และผู้ป่วยเรื้อรังอยู่ที่บ้านในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล 3) กระบวนการหลักของหน่วยจ่ายกลางประกอบด้วย 6 กระบวน ได้แก่ 1. การรับอุปกรณ์ ปนเปื้อน 2. การล้างทำความสะอาด 3. การบรรจุหีบห่อ 4. การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ 5. การจัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 6. การจัดจ่ายและนำส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของหน่วยจ่ายกลาง ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้รับบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่รุนแรงได้จำเป็นต้องมีการ	1. แนวทางปฏิบัติในหน่วยจ่ายกลาง 2. ข้อมูลตัวชี้วัดงานจ่ายกลาง 2563-2565

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	รายชื่อของเอกสาร/ หลักฐานประกอบอื่นๆ
ติดตามกำกับตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำหนด Set ที่ต้องใส่ Comply test ทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กำกับการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องนึ่งไอน้ำ จัดซื้อชุดอุปกรณ์ในการทดสอบความปราศจากเชื้อ หม้ออุ่นเชื้อ ชนิดอ่านผลภายใน 3 ชั่วโมง มีการทดสอบ Spore test 1 ครั้ง/ วัน และทุกครั้งที่นึ่งเครื่องมือผ่าตัด set คลอด Bowe dick test ทุกวันก่อนนึ่ง และรวบรวมรายงานตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและพัฒนา ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ ปี 2564-2567 (5เดือน) ผ่านเกณฑ์ 100%	

หมวด 7 ผลลัพธ์ทางการพยาบาล

7.1 ผลลัพธ์ด้านการบริการพยาบาล

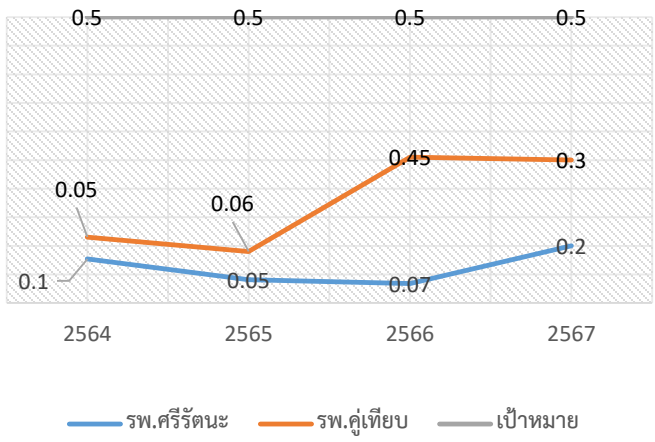
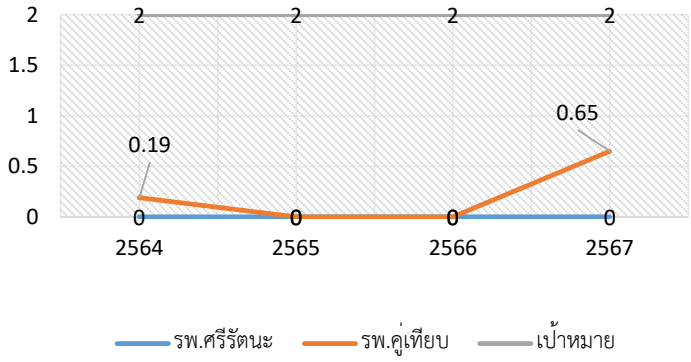




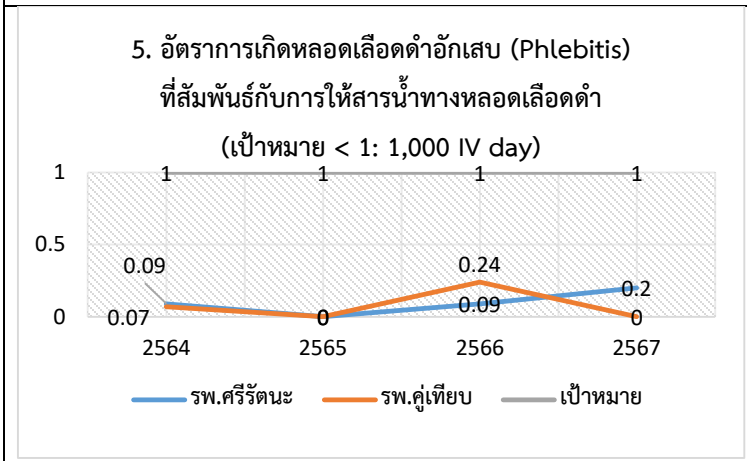
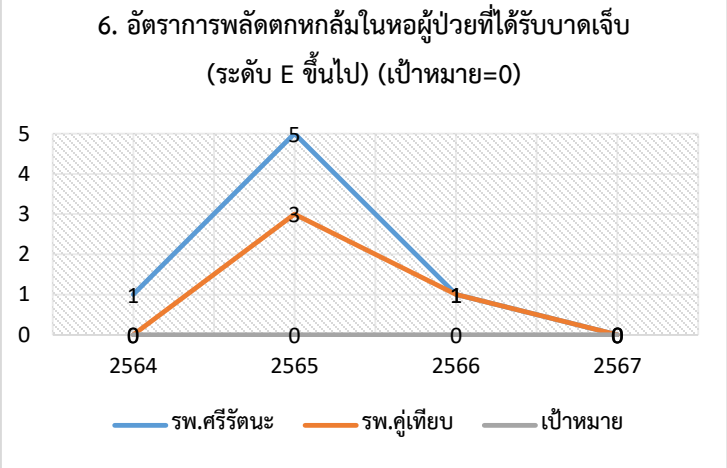
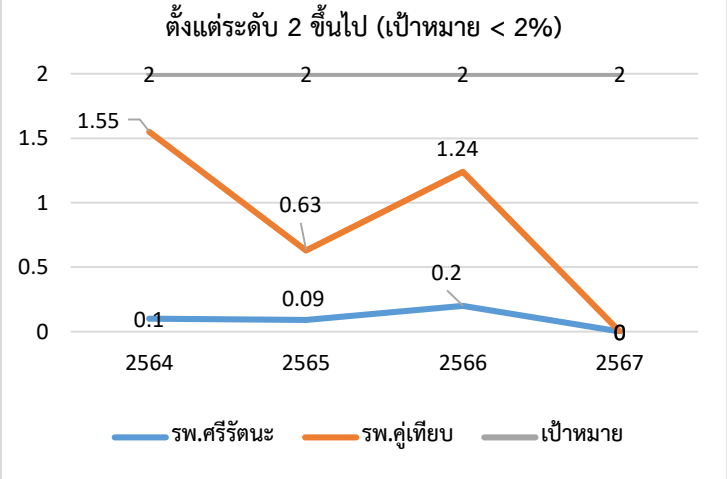
จากกราฟ พบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในค่าเป้าหมาย บุคลากรมีการปฏิบัติตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วย ตามนโยบาย Patient safety ดังนี้

1. เน้นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการในการตรวจสอบ Identity ของผู้ป่วยว่าถูกต้องตรงกับบุคคลที่จะให้การดูแลตามแผน (เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สิ่งส่งตรวจ หัตถการ) ก่อนที่จะให้การดูแล
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ตัวบ่งชี้อย่างน้อย 2 ตัว (เช่น ชื่อและวันเกิด) เพื่อยืนยันตัวบุคคลเมื่อแรกรับหรือเมื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นและก่อนที่จะให้การดูแล ไม่ควรใช้หมายเลขเตียงหรือห้องเป็นกำหนดให้วิธีการบ่งชี้ผู้ป่วยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
3. ในปี 2565 มีการใช้ระบบยืนยันตัวตนก่อนรับบริการผ่านตู้ Kiosk สามารถลดอุบัติการณ์ระบุตัวผู้ใช้บริการผิดคนจากขั้นตอนการทำบัตรได้

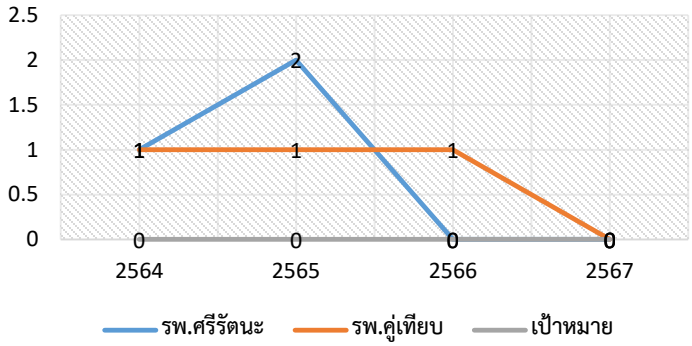
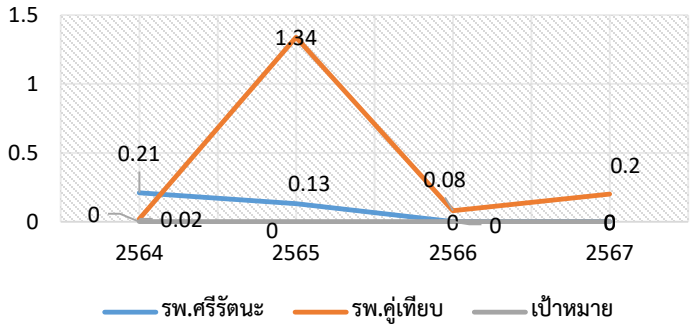
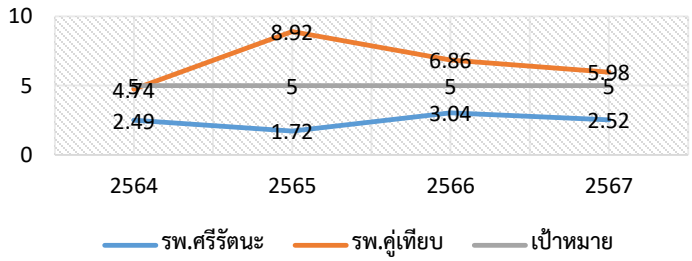
7.1 ผลลัพธ์ด้านการบริการพยาบาล

3. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (เป้าหมาย < 0.5: 1,000 วันนอน)  	อัตราการติดเชื้อในภาพรวมปี 2566-2567 มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังไม่เกินค่าเป้าหมาย ปี 2566 พบติดเชื้อตำแหน่ง Phlebitis 1 ราย ปี 2567 พบ 1 ราย จากการให้ยาความเข้มข้นสูง ได้นำ PVC care bundle มาใช้และพัฒนาการใช้พลาสเตอร์ใส ส่วนการติดเชื้อปี 2567 คือ ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเนื่องจากผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้น้อย มีอาการสำลัก จึงทบทวนร่วมกับทีม PCT กำหนดให้พยาบาลประเมินการกลืนเพื่อวางแผนการให้อาหารทางสายยาง จากการเฝ้าระวังยังไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม
4. อัตราการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการสวนคาปัสสาวะ (CAUTI) (เป้าหมาย < 2: 1,000 cath day)  	ไม่พบอุบัติการณ์การติดเชื้อ CAUTI เนื่องจาก งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อได้พัฒนาคุณภาพร่วมกับทีมพยาบาล ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติ CAUTI Bundle มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการล้างมือ การให้ความรู้กับญาติผู้ดูแล ติดตามนิเทศควบคุมกำกับ โดยหัวหน้างาน ICN และ ICWN อย่างต่อเนื่อง

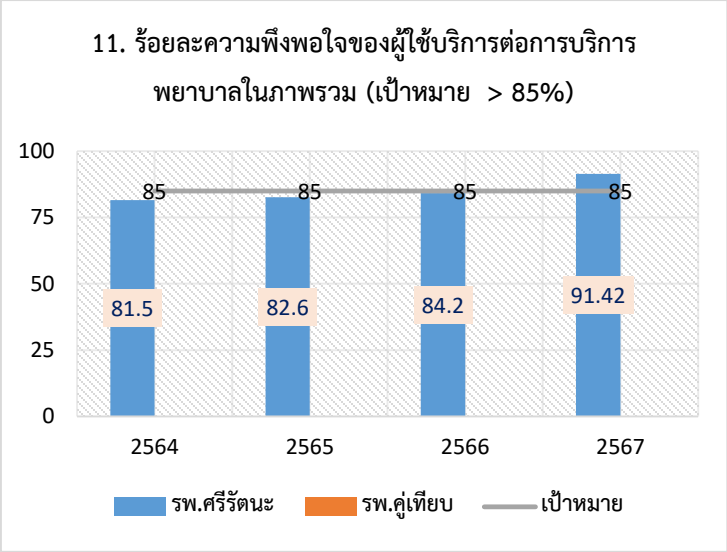
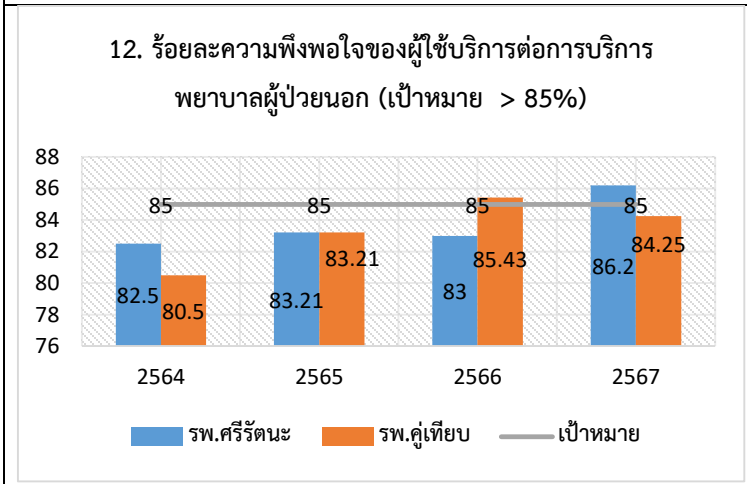
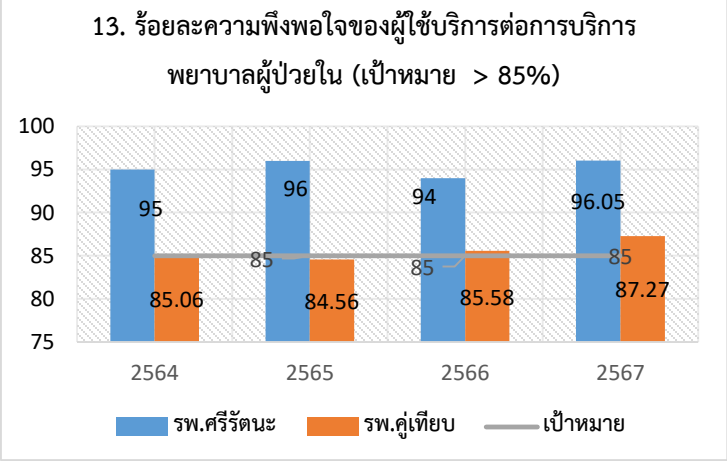
7.1 ผลลัพธ์ด้านการบริการพยาบาล

	ในภาพรวมอัตราการเกิด Phlebitis ที่สัมพันธ์กับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จากการปรับกระบวนการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้สารน้ำโดยยึดหลัก PVC Care bundle ผลลัพธ์ มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทาง การล้างมือ ติดตามนิเทศควบคุมกำกับ โดยหัวหน้างาน ICN และ ICWN อย่างต่อเนื่อง
	ในปีงบประมาณ 2564-2565 พบว่า อุบัติการณ์ส่วนใหญ่จะเกิดในเวรดึกทั้งในเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จึงทบทวนแนวทางการป้องกันโดยแนบแบบฟอร์ม Morse Fall Scale ในผู้ที่มีอาการหลงลืม วิงเวียนหน้ามืด และได้รับยาที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการง่วงซึม จัดเตียงที่มองเห็นชัดเจน ปรับเตียงให้อยู่ระดับต่ำสุด มีแสงสว่างเพียงพอ มีญาติเฝ้า ตรวจสอบไม้กั้นเตียงทุกครั้งที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ถ้าไม่อยู่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
	อุบัติการณ์ส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียงและนอนนาน จากปัญหาผิวหนังเปื้อนปัสสาวะจากการใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนาน มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พัฒนาแนวปฏิบัติ คือ การใช้ที่นอนลมในรายที่มีความเสี่ยง การมีแผ่นป้ายแสดงการพลิกตะแคงตัว การตรวจสอบและกำชับญาติในการเปลี่ยนผ้ารอง เมื่อมีปัสสาวะเปียกชุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

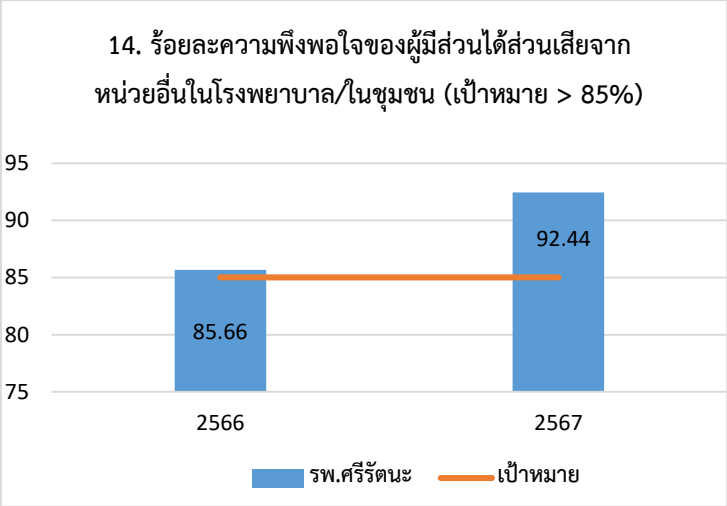
7.1 ผลลัพธ์ด้านการบริการพยาบาล

8. จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจัดท่าการผูกยึดและการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ (เป้าหมาย=0)  	จำนวนผู้ป่วยบาดเจ็บจากการผูกยึดปี 2564-2565 เป็นกลุ่มผู้ป่วย Alcohol withdrawal Syndrome มีการใช้ Alcohol withdrawal Scale ตาม Guideline และเน้นการปฏิบัติตามแนวทาง Alcohol withdrawal protocol โดยปฐมนิเทศแพทย์ พยาบาล และผูกยึดผู้ป่วยให้ครบทั้ง 4 รยางค์ โดยเทคนิคที่ถูกต้อง พร้อมกับคาดอกให้ผู้ป่วยได้ขยับได้น้อยที่สุด
9. อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาและสารน้ำ (ระดับ C ขึ้นไป) (เป้าหมาย < 1: 1,000 ใบสั่งยา)  	ผลการดำเนินงานอยู่ในค่าเป้าหมายและมีแนวโน้มลดลง จากการทบทวนอุบัติการณ์ มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการให้ยา สื่อสารทีมผู้ปฏิบัติ มีการนิเทศติดตามโดยพยาบาลหัวหน้างาน และเฝ้าระวังอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่อง
10. อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน (เป้าหมาย < 5%)  	ผลการดำเนินงานอยู่ในค่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มลดลง ผลการทบทวนพบว่า ผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง และมีภาวะแทรกซ้อน เช่น COPD, DM, HT, ESRD มีการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย มีการวางแผนการรักษาที่ครอบคลุมมากขึ้น มีระบบปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง มีการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและส่งต่อข้อมูลให้เครือข่าย เพื่อดูแลต่อเนื่อง

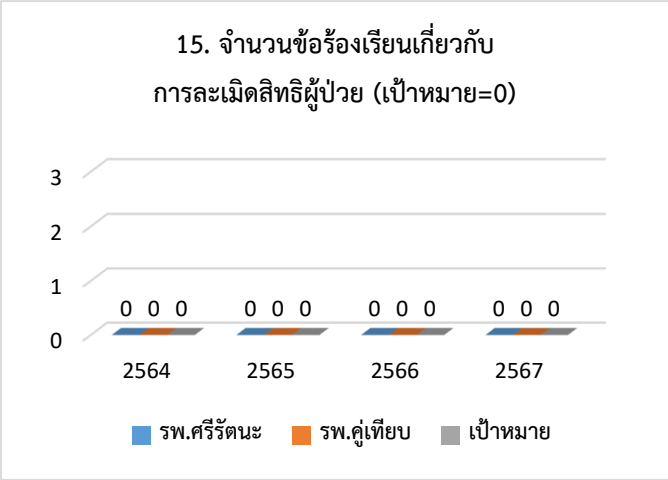
7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ

	จากกราฟ พบว่า ผลงานปี 2564-2566 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ในปี 2567 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการโดยรวม จากนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่างๆ ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรพัฒนาคุณภาพบริการ ส่งผลให้พยาบาลมีความตระหนักในการบริการที่ดีมากขึ้น
	ปี 2564-2566 พบว่า ผลงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ส่วนในปี 2567 ผลงานอยู่ในค่าเป้าหมาย จากการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลด้าน Smart hospital ส่งลให้ระบบบริการมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น มีการปรับปรุงด้านโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้มีความสวยงาม สะดวกสบาย และการพัฒนาด้านพฤติกรรมบริการของบุคลากร
	ผลการดำเนินงานอยู่ในค่าเป้าหมายที่กำหนด จากการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลด้าน Smart hospital ส่งลให้ระบบบริการมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น มีการปรับปรุงด้านโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้มีความสวยงาม สะดวกสบาย และการพัฒนาด้านพฤติกรรมบริการของบุคลากร

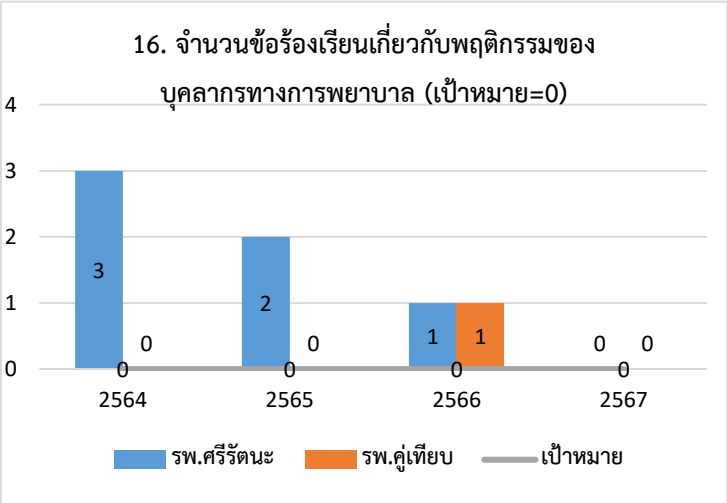
7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ



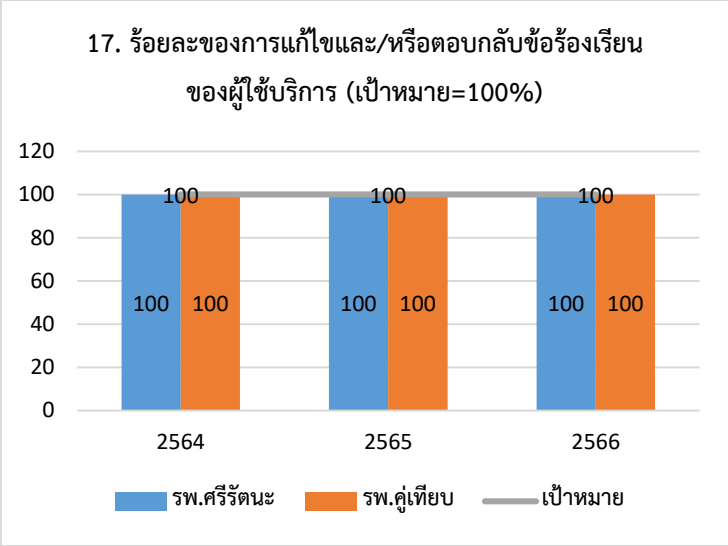
จากกราฟ พบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในค่าเป้าหมาย โดยในปี 2567 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้รับบริการและสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ และให้บริการด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง มากที่สุด ส่วนข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ การแสดงความเป็นมิตร และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี



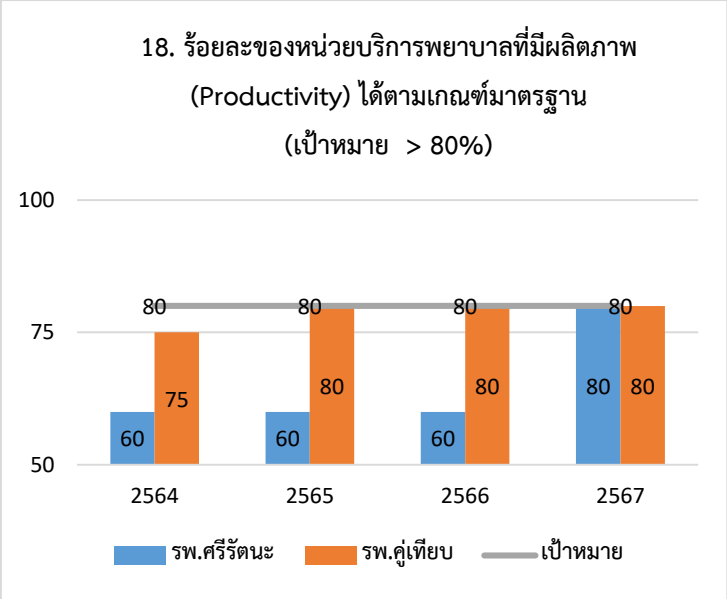
ผลการดำเนินงานไม่พบจำนวนข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติตามนโยบายการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย โดยการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีการสื่อสารสิทธิผู้ป่วยทุกจุดบริการ มีการควบคุมกำกับ นิเทศการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าเวรและหัวหน้างาน มีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิผู้ป่วย



ผลการดำเนินงาน พบว่า จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการมีแนวโน้มลดลง จากการทบทวนข้อร้องเรียนที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการสื่อสาร ได้ดำเนินการแก้ไขโดยประชุมชี้แจง นิเทศติดตามขณะปฏิบัติงาน มอบหมายให้หัวหน้างานมีการเมินพฤติกรรมบุคลากรเป็นระยะ และมีความต่อเนื่อง ในปี 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ

2 ผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ	
	ผลการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในค่าเป้าหมาย จากการที่องค์กรพยาบาล ให้ความสำคัญกับการแก้ไข/ตอบกลับข้อร้องเรียน เพื่อนำข้อร้องเรียนที่ได้รับมาดำเนินการแก้ไข ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

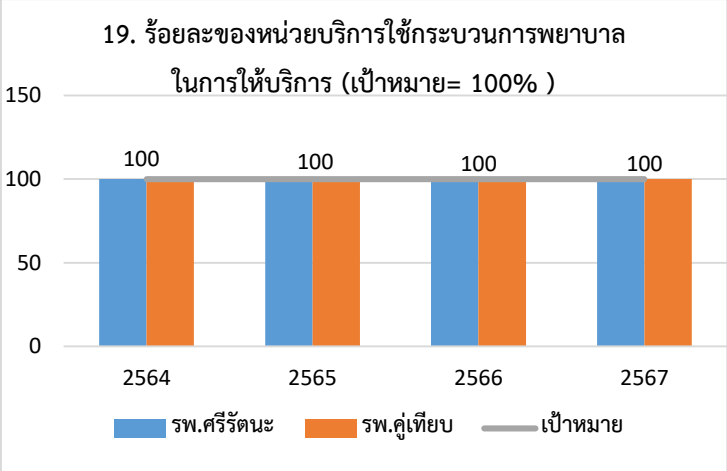
7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ



ในปี 2566 มีหน่วยงานที่มี Productivity ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ ER และ LR เมื่อทบทวน พบว่า

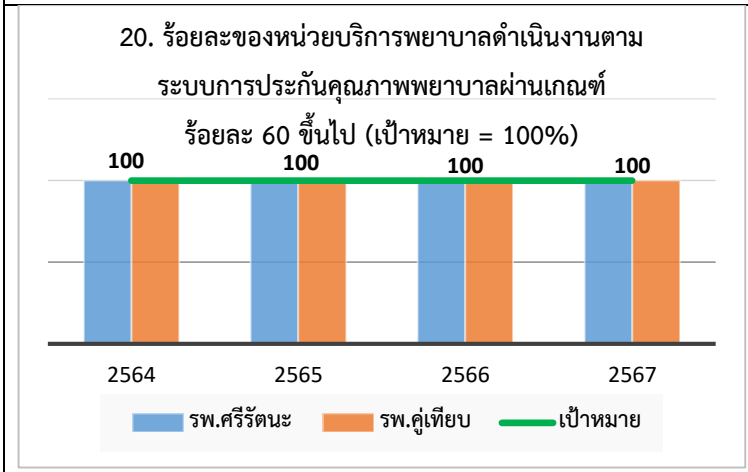
-ER มี Productivity ต่ำกว่าเกณฑ์ในเวรดึก ส่วนค่าเฉลี่ย Productivity ในเวรเช้า-บ่ายอยู่ในเกณฑ์ เนื่องจากเป็นหน่วยที่รับผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงคงอัตรากำลังทีมการพยาบาลเวรดึกไว้ มีการเพิ่ม Assignment ให้พยาบาลเวรดึกที่ไม่มีผู้รับบริการมีหน้าที่คัดแยกผู้ใช้บริการที่มาในเวลาเช้าตรู่ เช่น ผู้ป่วยที่มาฟอกเลือด ผู้ป่วย NCD Clinic และมีการทบทวนความถูกต้องการจำแนกประเภทผู้ป่วย ในปี 2567 พบว่า Productivity อยู่ในเกณฑ์

-LR มี Priductivity ต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากจำนวนผู้คลอดลดลง จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร คณะกรรมการบริหารองค์กร จึงพิจารณาปรับอัตรากำลังพยาบาลห้องคลอดให้เป็นอัตรากำลัเสริมที่ ER และ IPD

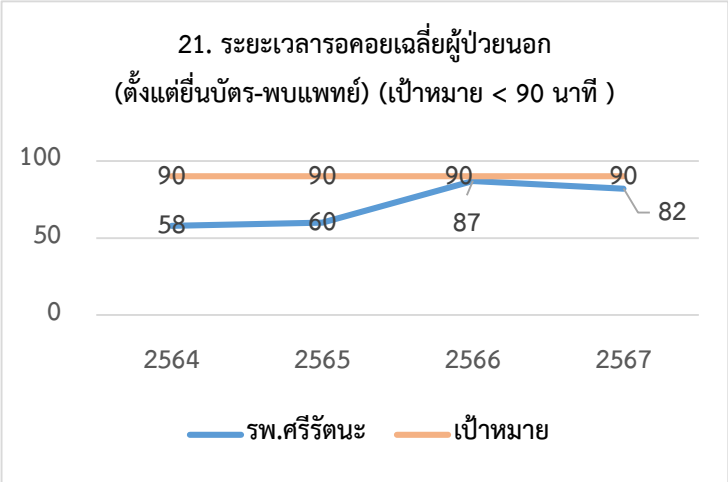


ผลการดำเนินงาน พบว่า ทุกหน่วยงานมีการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริการ เนื่องจาก เป็นการประกันคุณภาพการพยาบาล มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม โดยหัวหน้างานอย่างสม่ำเสมอ

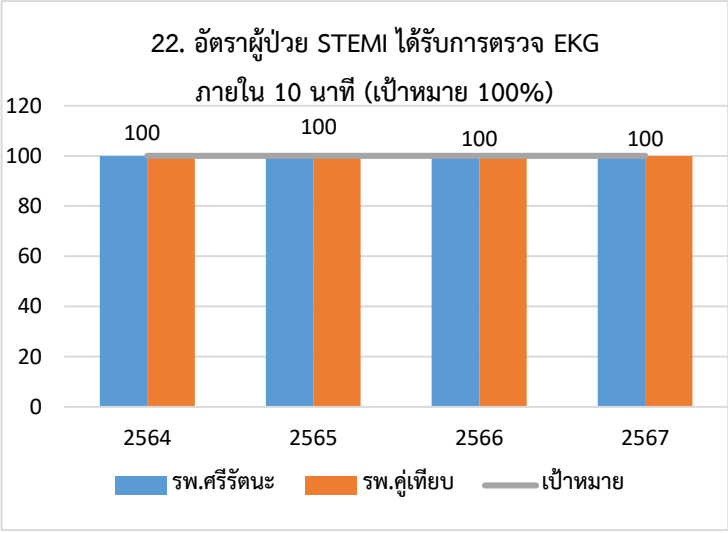
7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ



ผลการดำเนินงาน พบว่า ทุกหน่วยมีการประเมินตนเองตามมาตรฐานการประกันคุณาพขการพยาบาลของแต่ละหน่วยงาน ทุก 6 เดือน มีการแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ และผ่านเกณฑ์การระเมินทุกหน่วยงาน

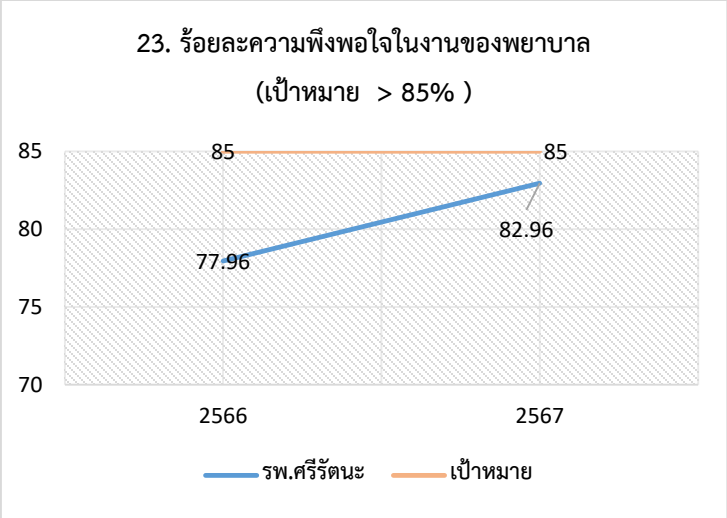


ผลการดำเนินงานอยู่ในค่าเป้าหมาย ปี 2564-2565 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยน้อยกว่าปี 2566-2567 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 และนโยบาย Social distancing ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและระยะเวลารอคอยลดลง ส่วนในปี 2566-2567 ระยะเวลารอคอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย เข้าสู่สถานการณ์ปกติ



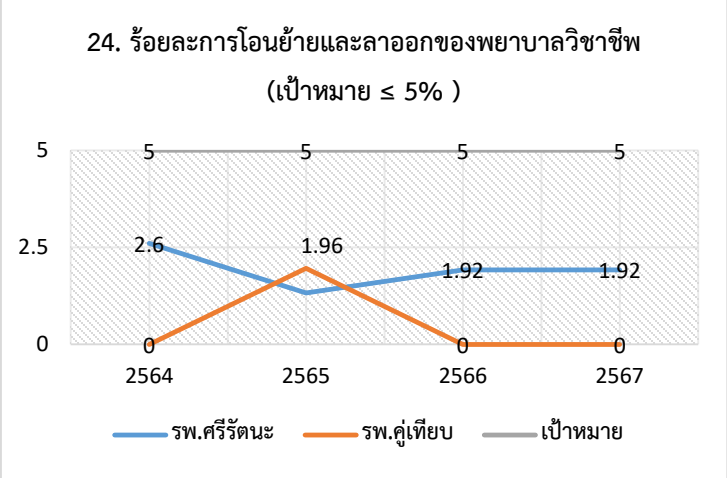
ผลการดำเนินงานอยู่ในค่าเป้าหมาย จากการจัดให้มี Triage Nurse มีการประเมินผู้ป่วยให้เข้าสู่ Fast Track ตาม Chest Pain Checklist ซึ่งครอบคลุมอาการของ STEMI ทั้ง Typical และ Atypical chest painอายุ Risk factor สามารถคัดแยกผู้ป่วยเข้าสู่ STEMI pathway ส่งผลให้สามารถประเมินผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ผู้ป่วยได้รับการตรวจ EKG ภายใน 5 นาทีทุกราย สามารถประกันคุณภาพการพยาบาลได้

7.4 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร



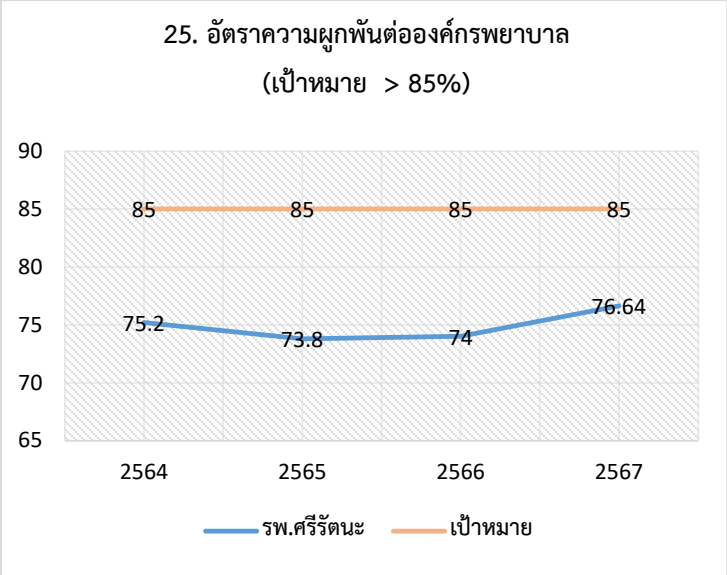
จากการประเมินความพึงพอใจในงาน พบว่า คะแนนความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินข้อคำถามที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด 3 อันดับแรก คือ

1. ความพึงพอใจต่อการพิจารณาความดีความชอบ (74.07%)
2. ความพึงพอใจในการบรรจุแต่งตั้ง (77.98%)
3. ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการในการทำงาน และนอกเหนือจากการทำงาน (79.81%)

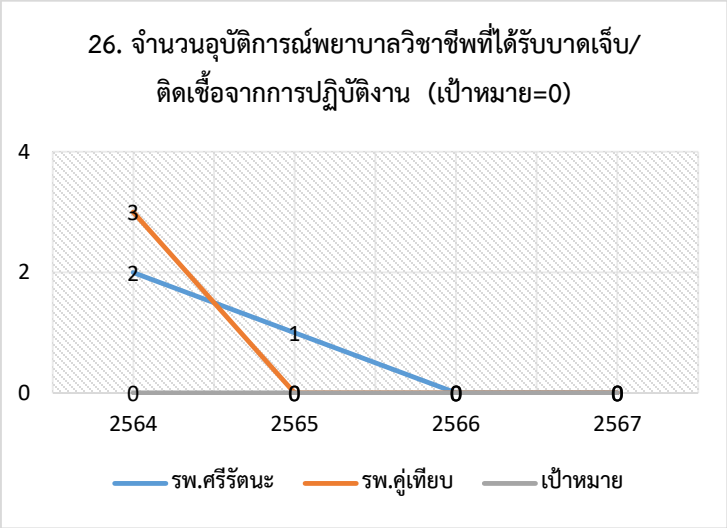


ในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 มีพยาบาลวิชาชีพขอโอนย้าย ปีละ 1 คน โดยมีเหตุผลในการโยกย้าย เพื่อไปดูแลบุคคลในครอบครัว

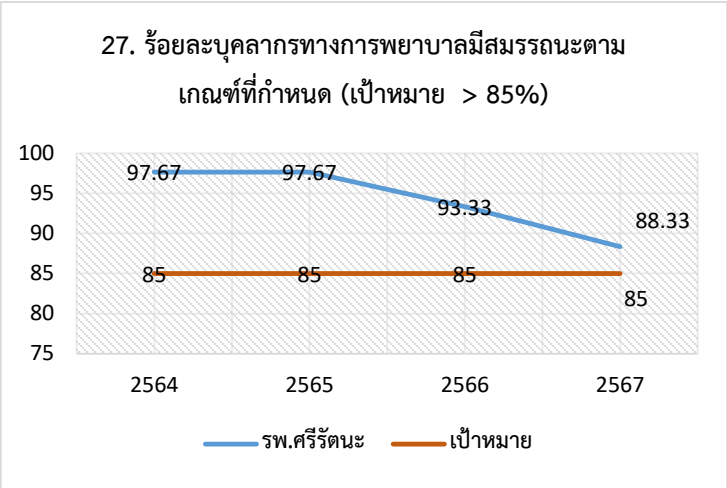
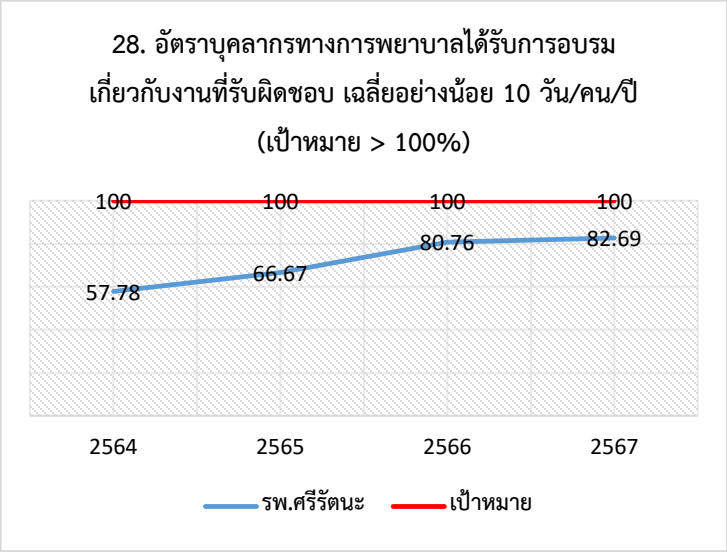
7.4 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร



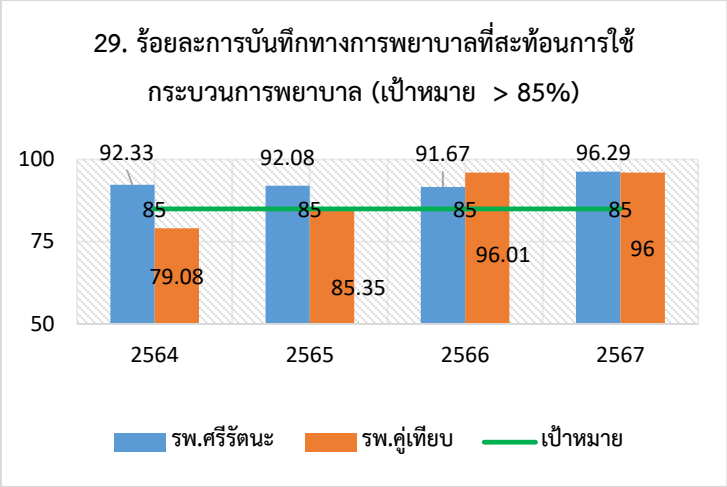
ผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล พบว่า ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากผลการประเมิน พบว่า ด้านที่มีคะแนนความผูกพันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความต้องการในการดำรงความเป็นสมาชิกขององค์การ (77.61%) รองลงมา คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (76.93%) และการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ (71.93%) ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ (68.86%) ทีมบริหารจึงมีการประชุม ทบทวน เพื่อวางแผนในการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพให้อยู่ในค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี



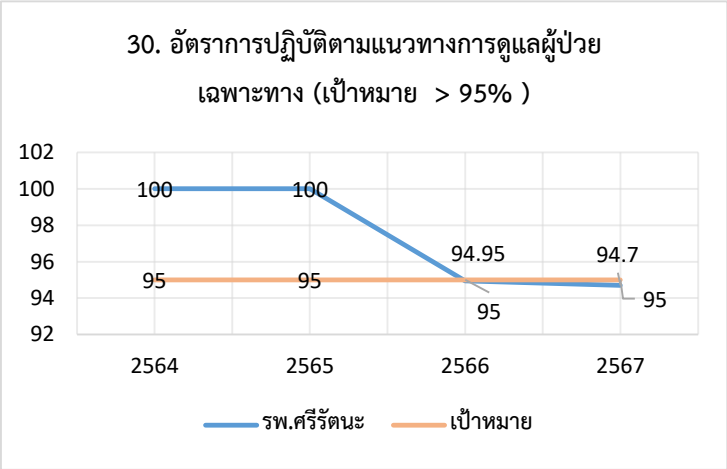
ในปี 2564-2565 พยาบาลวิชาชีพได้รับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มตำ และสัมผัสสารคัดหลั่ง ICWN จึงจัดประชุมทบทวนอุบัติการณ์ มีการปฐมนิเทศบุคลากร ทบทวนแนวทางปฏิบัติการป้องกันเข็มทิ่มตำ/สัมผัสสารคัดหลั่ง การกำหนดให้ทิ้งของมีคมในกล่องที่เตรียมไว้ หัวหน้าหน่วยงานมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ในปี 2567 ไม่พบอุบัติการณ์

7.4 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร	
	ประเมิน Common competency 3 เรื่อง CFC 1: ความสามารถในการบริหารยา สารน้ำ เลือดและส่วนประกอบของเลือด CFC 2: ความสามารถในการบรรเทาความเปวด CFC 3 : ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล ผลการประเมิน พบว่า บุคลาการผ่านการประเมินตามค่าเป้าหมาย Competency ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ความสามารถในการบริหารยา สารน้ำ เลือดและส่วน ประกอบของเลือด
	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายโดยพบว่า ในปี 2564-2565 มีสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จึงส่งผลต่อการจัดอบรมของหน่วยงานต่างๆ ปี 2566-2567 อัตราการได้รับการอบรมของบุตลากรเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล การจัดอบรมในระบบออนไลน์มากขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรมเพิ่มขึ้น

7.5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ

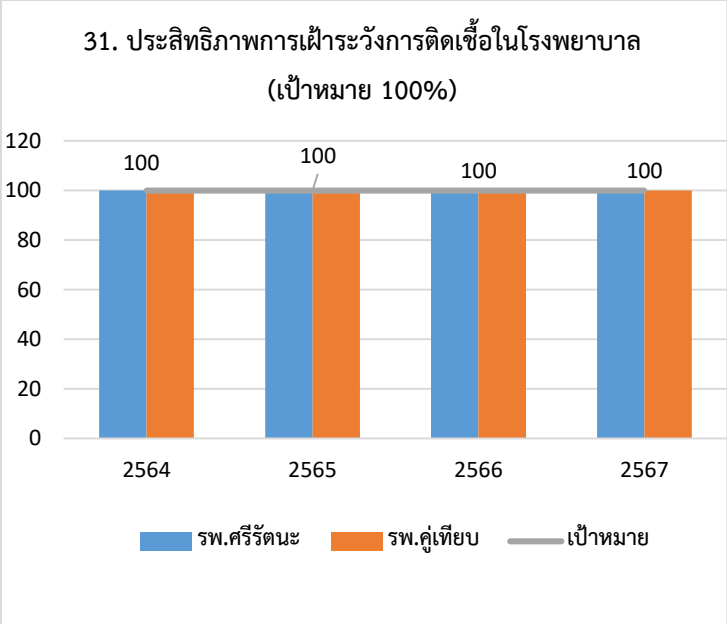


ผลการดำเนินงานอยู่ในค่าเป้าหมาย จากการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลโดยหัวหน้างาน มีการพัฒนาการบันทึกการพยาบาลรายโรค ปัญหาที่พบในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ได้แก่ การประเมินผู้ป่วยไม่ครบถ้วน และขาดการประเมินอาการซ้ำในผู้ป่วยบางราย



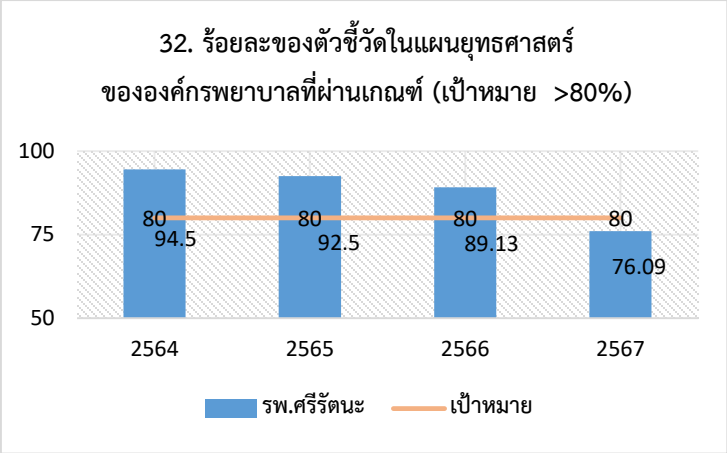
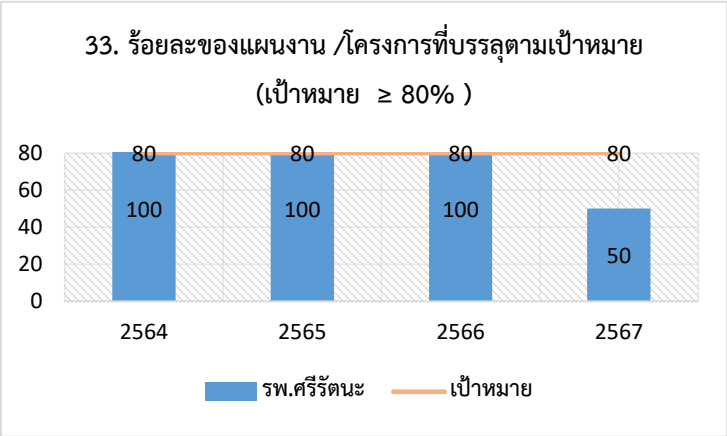
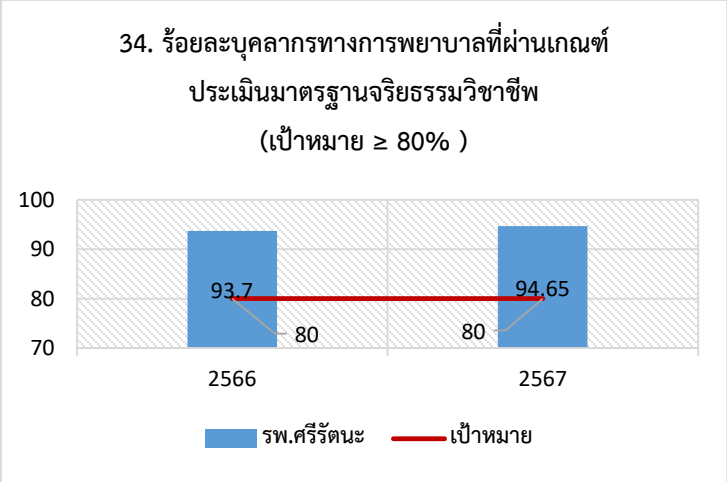
อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง อยู่ในค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นบริการพิเศษที่เปิดให้บริการ จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ในปี 2566 ได้เปิดการให้บริการคลินิกเฉพาะทาง หลายสาขามากขึ้น ได้แก่ คลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมทั่วไป คลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิกตา โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ชัดเจน ด้วยข้อจำกัดด้านอัตรากำลัง จึงมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงเกิดอุบัติการณ์ จากการไม่ปฏิบัติตามแนวทาง ในปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง คือ พบผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ หลังการส่องกล้อง 1 ครั้ง และการเตรียมอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ จำนวน 1 ครั้งในปี
ในปี 2567 พบอุบัติการณ์ จำนวน 1 ครั้ง คือ การประสานงาน ผิดพลาด ทำผู้ป่วยรอนานและไม่ได้พบแพทย์

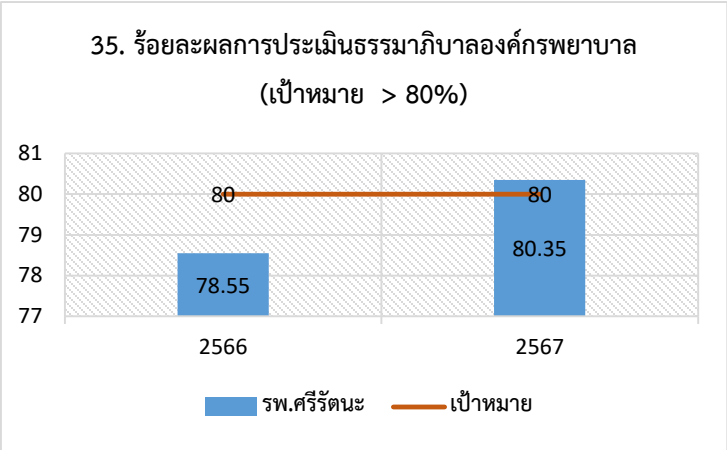
7.5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ



ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมป้องกันการติดเชื้อส่งผลให้อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย มีการประสานงานในการพัฒนาคุณภาพร่วมกับทีมพยาบาลทุกหอผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางปฏิบัติที่ได้รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการ Update ความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบ Targeted surveillance ในตำแหน่งที่สำคัญ มีแนบใบเฝ้าระวัง ทดสอบความรู้ ICWN ให้ความรู้หน้างานกับเจ้าหน้าที่ ICN มีการทำ Point prevalence survey ปีละ1 ครั้ง นอกจากนั้นมีการติดตามค้นหาในกลุ่มผู้ป่วยนอนนานมากกว่า 7 วัน และกลุ่ม Refer พบว่า มีการรายงานตรงกัน

7.6 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร

	ผลการดำเนินงาน ปี 2564-2566 อยู่ในค่าเป้าหมาย จากการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มีการมอบหมายตัวชี้วัดระดับทีมหน่วยงาน บุคคลมีคณะกรรมการสารสนเทศ มีหน้าที่ติดตามข้อมูล และการนิเทศติดตามโดยหัวหน้างาน/หัวห้าพยาบาล มีการทบทวนและประเมินตัวชี้วัดทุกเดือน ในปี 2567 การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นช่วงระหว่างปีงบประมาณ
	จากผลการดำเนินงานในปี 2564-2566 พบว่า แผนงานและโครงการกลุ่มงานการพยาบาล ได้ดำเนินการตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการกำกับติดตามการทำงานของคณะกรรมการสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ทุกเดือน ในปี 2567 การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นช่วงระหว่างปีงบประมาณ
	องค์กรพยาบาลมีการพัฒนาให้บุคลากรทางการพยาบาล ยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการปลูกฝังให้พยาบาลต้องมีใจเมตตา กรุณาต่อผู้ป่วย ต้องตระหนักถึงประโยชน์ของผู้ป่วยหรือสังคม มีการดูแลผู้ป่วย “ดุจญาติมิตร” โดยการมอบนโยบายทีมผู้บริหาร มีบทบาทในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม มีการนิเทศงาน การเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านจริยธรรม

7.6 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร	
	การบริหารงานองค์กรพยาบาล คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักสำคัญ เน้นความยุติธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนางานร่วมกัน มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้คะแนนประเมินธรรมาภิบาลปี 2567 เพิ่มขึ้น และอยู่ในค่าเป้าหมาย

3. ส่วนสรุป: ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

หมวด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาต่อเนื่อง
หมวด 1 **การนำองค์กร**	- หัวหน้าพยาบาล เป็นผู้มีภาวะผู้นำสูงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ ในกระบวนการวิเคราะห์องค์กร กำหนด ทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง และ เป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงและระดับโรงพยาบาล - มีการสื่อสาร และถ่ายทอดนโยบายที่ชัดเจนให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร - มีช่องทางรับข้อมูล ความคิดเห็นหลายช่องทาง เพื่อการบริหารองค์กร - มีการแบ่งโครงสร้างการพยาบาล ทั้งหมด 6 หน่วยงาน มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ ชัดเจน	- นำข้อมูลจากผลการนิเทศ มาประกอบการ วางแผนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง - การนำข้อมูล ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ระบบการทำงาน - ความต่อเนื่องในการติดตามกำกับงาน

หมวด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาต่อเนื่อง
	- มีการกำกับติดตามนิเทศ ช่วยให้การถ่ายทอดวิธี ดำเนินงาน กำกับติดตามมีความคล่องตัว โดยมอบหมายให้หัวหน้างานกำกับติดตามในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ จะเป็นหัวหน้าเวร นิเทศกำกับติดตามเพื่อบรรลุทิศทางขององค์กร	
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	- หัวหน้าพยาบาลเน้นการมีส่วนร่วมของทีมผู้บริหาร และบุคลากรองค์กรพยาบาล ใน การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis - มีการนำแผนกลยุทธ์หลักมาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้แผนกลยุทธ์หลักบรรลุตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น - มีวิธีการถ่ายทอดและสื่อสารแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication) ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง - มีการทบทวนและประเมินแผนและปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ - มีการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย วางแผนพัฒนาโดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA	- ควรมีการติดตามและทบทวนตัวชี้วัดและปรับเปลี่ยนแผนในการดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
หมวด 3 ผู้ใช้บริการ	- องค์กรมีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้งโดยใช้ผู้ประเมินจากภายนอก ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ใกล้เคียงความจริง - มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลายช่องทาง - หน่วยงานมีการประเมินภาวะเสี่ยงตั้งแต่	- พัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำรูปแบบการประเมินผลออนไลน์เพื่อสอดคล้องกับ Smart Hospital - เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูล จากช่องทางอื่นๆ เพื่อมาปรับปรุง

หมวด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาต่อเนื่อง
	แรกรับ เพื่อปรับบริการให้เหมาะสม - มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ	พัฒนาระบบงาน และ มอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูล รายงาน
หมวด 4 **การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้**	- หัวหน้าพยาบาลส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงาน - มีบุคลากรพยาบาลทุกหน่วยงานรับผิดชอบลงบันทึกจัดเก็บข้อมูลการดูแลผู้ป่วยแบบ real time ทุกเวรทุกวันรวมทั้งมีการ จัดเก็บบันทึกความเสี่ยงด้านการพยาบาล ในโปรแกรมความเสี่ยงทุกครั้งเมื่อมี -นำข้อมูลมาวัดวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน -การนำหลักฐานทางวิชาการสู่การปฏิบัติ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ ผลงานวิชาการระดับโรงพยาบาล ระดับโซน ระดับจังหวัด	-พัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศทางการพยาบาล - ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน สร้างผลการ พัฒนา งานวิชาการ นวัตกรรมอย่างน้อย หน่วยละ 1 เรื่อง ทุก 1-2 ปี และนำสู่ ตัวชี้วัดรายบุคคลประกอบการ ประเมินผลปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง -พัฒนาระบบการจัดการ KM และงานวิจัย/R2R ทางการพยาบาล
หมวด 5 **บุคลากรพยาบาล**	- มีนโยบายและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดอัตรากำลังที่ชัดเจน - ผู้นำกระจายอำนาจ และการมอบอำนาจในการบริหารจัดการ ตัดสินใจ - มีการประเมินความรู้ความสามารถ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกปี - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง - มีระบบการดูแลสุขภาพของบุคลากร - มีการประเมินความผูกพันต่อองค์กร - ประเมินบรรยากาศในการทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน	- ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พร้อมสำหรับการขึ้นสู่ตำแหน่ง - มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับอย่างชัดเจน - มีกิจกรรมที่สร้างเสริมความสามัคคีในกลุ่มมากขึ้น

หมวด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาต่อเนื่อง
หมวด 6 การปฏิบัติการพยาบาล	- นโยบายขององค์กรพยาบาลมุ่งเน้นให้พยาบาลทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม - การกำหนดค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ และ 7 Aspect of care เป็นหลักในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการพยาบาล - การนำ EBP สู่การปฏิบัติ และมีการทบทวนระเบียบปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และเอกสารอ้างอิงให้ทันสมัยอยู่เสมอ - มีระบบการควบคุมกำกับ การปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างาน และทีมการนิเทศ ทั้งใน และนอกเวลา - การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเหมาะสม	1. พัฒนาศักยภาพผู้นิเทศ 2. พัฒนาผู้ปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการถ่ายทอดประสบการณ์ในงาน
หมวด 7 ผลลัพธ์ทางการพยาบาล	- มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมคุณภาพแต่ละหน่วยงาน - มีการนำผลการทบทวนมาปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน	- พัฒนาระบบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน - นำผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบงาน